Perfil V3 · código por código

Reumatología

Los 35 códigos del Perfil de Conocimientos EUNACOM v3 (2026) de Reumatología, uno por uno: el nivel que exige el examen, dónde se enseña en nuestros libros, lo que hay que saber en resumen y una pregunta.

Niveles del Perfil — Diagnóstico: **Sospecha** (reconocer y derivar) o **Específico** (confirmar). Tratamiento: **Inicial** (estabilizar y derivar) o **Completo**. Seguimiento: **Derivar**, **Completo** o **No requiere**.

Situaciones clínicas 25 códigos

1.11.1.001 Artritis psoriática

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 16.5 Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas · Tema 9.18 Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en paciente con psoriasis (afecta al 15-30% de ellos) que presenta dactilitis («dedo en salchicha»), artritis de interfalángicas distales u oligoartritis asimétrica, entesitis o lumbago inflamatorio.
- Pistas: distrofia ungueal (pitting, onicólisis, manchas en gota de aceite), seronegatividad (FR y anti-CCP negativos) y radiografía con «lápiz en copa» y periostitis en fases avanzadas; forma mutilante con telescopaje.
- Diferencial: artritis reumatoide (nunca da dactilitis y respeta las IFD), gota, artrosis nodal.
- Manejo inicial: AINE para el dolor e infiltración con corticoide en sinovitis o dactilitis localizada; evitar corticoides sistémicos (rebote de la psoriasis).
- Seguimiento: derivar a reumatología para metotrexato semanal + ácido fólico (FARME de elección, trata piel y articulaciones) y biológicos (anti-TNF, anti-IL-17) si es refractaria o axial.

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 29

Una paciente de 42 años presenta artritis de las articulaciones interfalángicas distales y proximales de ambas manos, con afectación reciente de una articulación metatarsofalángica. Al examen físico, además de las artritis descritas, presenta múltiples depresiones en las uñas de las manos y engrosamiento de las uñas de los pies. **¿A qué tipo de artritis corresponde este cuadro?**

A) Reumatoide
B) Reactiva
C) Psoriática
D) Gotosa
E) Lúpica

Respuesta C. Artritis de interfalángicas distales, con pitting ungueal y engrosamiento ungueal, es una artritis psoriásica clásica, incluso sin mencionar placas cutáneas, porque las uñas pueden dar la pista antes que la piel.

Pregunta real · EUNACOM 2017 · Pregunta 38

Hombre de 38 años con antecedente de psoriasis en placas consulta por tumefacción dolorosa difusa y uniforme del segundo dedo de la mano izquierda, que adquiere un aspecto engrosado cilíndrico en "salchicha". Al examen se constata dolor en interfalángicas proximales y distales con dolor a la palpación del trayecto del tendón flexor. Las uñas muestran piqueteado puntiforme (pitting). ¿Cómo se denomina este hallazgo semiológico característico?

A) Nódulos de Heberden
B) Dactilitis ("dedo en salchicha")
C) Pannus sinovial erosivo
D) Tofo gotoso interarticular
E) Eritema nudoso digital

Respuesta B. La dactilitis o "dedo en salchicha" es la inflamación uniforme y difusa de la totalidad de un dedo ocasionada por la combinación simultánea de sinovitis articular y tenosinovitis de los tendones flexores. Es una manifestación característica y altamente específica de las espondiloartropatías, particularmente de la Artritis Psoriásica y de la Artritis Reactiva.

Pregunta real · EUNACOM 2023 · Pregunta 41

¿Cuál de los siguientes hallazgos en la radiografía simple de manos es característico y distintivo de la fase destructiva de la Artritis Psoriásica en articulaciones interfalángicas distales?

A) Osteopenia yuxtaarticular en banda aislada sin neoformación ósea
B) Deformidad destructiva con aspecto en lápiz en copa (pencil-in-cup)
C) Geodas subcondrales gigantes con esclerosis circular pura
D) Condrocalcinosis del fibrocartílago triangular
E) Subluxación atloaxoidea aislada

Respuesta B. La imagen radiológica en "lápiz en copa" (pencil-in-cup) en las articulaciones interfalángicas de las manos es clásica de la artritis psoriásica. Se produce por la reabsorción y afilamiento del extremo de la falange media ("lápiz") junto con la erosión cóncava y proliferación perióstica de la base de la falange distal ("copa").

Pregunta de práctica

Hombre de 36 años con antecedente de psoriasis en placas en codos de 5 años de evolución consulta por dolor e hinchazón en el tercer dedo de la mano derecha de 3 semanas. Al examen físico el dedo completo luce uniformemente engrosado, eritematoso y tumefacto, con aspecto de salchicha, con dolor exquisito a la palpación del tendón flexor y sinovitis de la articulación interfalángica distal. Las uñas muestran múltiples depresiones puntiformes en dedal (pitting) y desprendimiento ungueal distal. El factor reumatoide y los anticuerpos anti-CCP son negativos. **¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y cuál es el fármaco modificador sintético de primera elección?**

A) Artritis Psoriásica con dactilitis; indicar Metotrexato oral semanal más ácido fólico
B) Artritis reumatoide seronegativa; indicar Sulfasalazina en monoterapia
C) Gota tofácea poliarticular; prescribir Alopurinol en dosis altas inmediatas
D) Osteoartritis erosiva de manos; prescribir condroitín sulfato y paracetamol SOS
E) Tenovaginitis infecciosa bacteriana; hospitalizar para drenaje quirúrgico y cloxacilina

Respuesta A. El cuadro clínico es diagnóstico de Artritis Psoriásica: paciente con antecedente de psoriasis cutánea que debuta con dactilitis ("dedo en salchicha"), compromiso de interfalángica distal, distrofia ungueal característica (pitting y onicólisis) y seronegatividad inmunológica (FR y anti-CCP negativos). El fármaco modificador de la enfermedad sintético de primera elección para la artritis psoriásica periférica es el Metotrexato, que ayuda a controlar simultáneamente la piel y las articulaciones.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 111 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 40 años presenta artri8s de muñecas y de ar8culaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales y distales de ambas manos, de 6 semanas de evolución. Recientemente se agregó dolor y aumento de volumen generalizado del segundo ortejo derecho, que le dificulta la marcha. Al examen Fsico se aprecia aumento de volumen y eritema de las ar8culaciones descritas, más lesiones deprimidas pun8formes en las uñas de las manos, con engrosamiento de las uñas de los pies. El cuadro descrito corresponde a una artri8s de 8po:

A) Reumatoide
B) Infecciosa
C) Reac2va
D) Psoriá2ca
E) Gotosa

Respuesta D. Dactilitis (dedo en salchicha) con artritis de interfalángicas y compromiso ungueal con depresiones puntiformes y engrosamiento de las uñas corresponde a una artritis psoriásica. La reumatoide no produce dactilitis ni lesiones ungueales de ese tipo, la gotosa es de inicio agudo en una articulación, y la reactiva y la infecciosa tienen otros antecedentes.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 129 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 30 años presenta lumbago de 6 meses de evolución, intenso, que limita sus actividades y que es más molesto en la mañana y va cediendo durante el día. Al examen físico tiene lesiones descamativas en las rodillas y punteado ungueal y el examen de la columna muestra limitación a la flexión, con test de Schöber modificado de 2 cm. Se solicitan exámenes que muestran VHS: 60 mm/h, PCR: 5,0 mg/dl, anticuerpos antinucleares y factor reumatoide negativos. ¿Cuál es el examen de elección para establecer el diagnóstico en este paciente?

A) Radiografía de columna lumbosacra
B) Radiografía de columna dorsolumbar
C) TAC de columna lumbosacra
D) Resonancia magnética de columna dorsolumbar
E) Resonancia magnética de articulaciones sacroilíacas

Respuesta E. Es una artritis psoriática clásica, con la pelviespondiloartropatía, que se estudia con RMN de sacroilíacas, como el mejor examen, considerado de elección actualmente (por eso la dejamos como correcta), aunque se suele iniciar con la Rx de sacroilíacas.

1.11.1.002 Artritis reactivas

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.19 Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Artritis reactiva: sinovitis aséptica 1-4 semanas después de una infección urogenital (Chlamydia trachomatis) o entérica (Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia); HLA-B27 en hasta 80%.
- Clínica: oligoartritis asimétrica de extremidades inferiores (rodillas, tobillos), dactilitis de ortejos, entesitis; tríada de Reiter: uretritis, conjuntivitis y artritis.
- Lesiones mucocutáneas: balanitis circinada indolora, queratodermia blenorrágica palmoplantar, aftas orales indoloras.
- Confirmación: artrocentesis obligatoria con líquido inflamatorio (20.000-50.000 leucocitos) pero Gram y cultivo estériles; descartar artritis séptica y gonococia diseminada (tenosinovitis, pústulas, responde a ceftriaxona).
- Manejo inicial: AINE en dosis plenas (naproxeno, indometacina); doxiciclina o azitromicina si hay infección por Chlamydia, tratando también a la pareja; corticoide intraarticular si es refractaria.
- Seguimiento: derivar a reumatología si persiste >3-6 meses (sulfasalazina) o hay compromiso axial.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM 2020 · Pregunta 15

¿Cuál de las siguientes combinaciones de hallazgos clínicos conforma la denominación clásica del Síndrome de Reiter?

A) Artritis reumatoide, esplenomegalia y neutropenia
B) Uretritis, conjuntivitis y artritis periférica asimétrica
C) Xerostomía, xeroftalmia y artralgias
D) Calcinosis, fenómeno de Raynaud y esclerodactilia
E) Aftas orales, aftas genitales y uveítis con hipopión

Respuesta B. El Síndrome de Reiter se define clásicamente por la tríada clínica de: 1) Uretritis no gonocócica (o cervicitis), 2) Conjuntivitis bilateral y 3) Artritis periférica asimétrica de extremidades inferiores. La tríada de AR + esplenomegalia + neutropenia corresponde al síndrome de Felty, y las aftas orogenitales más uveítis a la enfermedad de Behçet.

Pregunta real · EUNACOM 2023 · Pregunta 30

¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al líquido sinovial obtenido mediante artrocentesis en un paciente con Artritis Reactiva aguda es CORRECTA?

A) Presenta invariablemente tinción de Gram con diplococos gramnegativos intracelulares abundantes
B) Es francamente inflamatorio (recuentos de 20.000 a 50.000 leucocitos/mm³) pero rigurosamente ESTÉRIL al cultivo
C) Es no inflamatorio con viscosidad normal y menos de 200 leucocitos/mm³
D) Contiene cristales de urato monosódico birrefringentes fuertemente negativos
E) Presenta microhemorragias masivas por fragilidad capilar pura

Respuesta B. El líquido articular en la artritis reactiva es de tipo inflamatorio (frecuentemente turbio con 20.000 a 50.000 leucocitos/mm³ de predominio polimorfonuclear), pero es típicamente estéril; tanto el Gram como los cultivos bacterianos estándar resultan negativos, confirmando su naturaleza inmunológica postinfecciosa aséptica.

Pregunta de práctica

Hombre de 23 años consulta por dolor e inflamación en rodilla izquierda y tobillo derecho de 10 días de evolución, con gran dificultad para apoyar el pie. Refiere que hace 3 semanas presentó ardor al orinar con escasa secreción uretral blanquecina matinal tras un contacto sexual de riesgo sin protección, a lo que siguió ojo rojo bilateral leve que resolvió espontáneamente. Al examen físico destaca rodilla izquierda con derrame articular a tensión y dactilitis en el segundo dedo del pie derecho. En el glande se aprecian erosiones circulares confluentes no dolorosas (balanitis circinada). La artrocentesis de rodilla da salida a líquido turbio con 32.000 leucocitos/mm³ con Gram negativo y cultivos bacterianos negativos. **¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y cuál es la conducta terapéutica indicada?**

A) Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter); iniciar AINEs a dosis plenas, tratar Chlamydia con Doxiciclina y tratar obligatoriamente a su pareja sexual

B) Artritis séptica gonocócica; hospitalizar para Ceftriaxona 1 g endovenoso diario por 14 días

C) Gota poliarticular aguda; iniciar Alopurinol 300 mg al día de inmediato

D) Lupus eritematoso sistémico; iniciar Prednisona e Hidroxicloroquina oral

E) Espondilitis anquilosante avanzada; indicar terapia biológica Anti-TNF inmediata

Respuesta A. El cuadro clínico reúne la tríada clásica del Síndrome de Reiter (uretritis previa, conjuntivitis y oligoartritis asimétrica de extremidades inferiores con dactilitis) junto a la lesión mucocutánea patognomónica de balanitis circinada y líquido articular inflamatorio estrictamente estéril. El manejo requiere AINEs a dosis plenas para la inflamación articular, tratamiento antimicrobiano para Chlamydia trachomatis con doxiciclina o azitromicina, y tratamiento epidemiológico mandatorio a la pareja sexual.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 116 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 20 años, con antecedente de gastroenteritis aguda hace dos semana, consulta por dolor en tobillo derecho desde hace 1 día. Refiere haber presentado molestias similares hace una semana en rodilla y pie izquierdo. Al examen físico destaca tobillo derecho con eritema leve, sin otros hallazgos. El diagnóstico más probable en este caso es:

A) Artritis por cristales

B) Artritis por stafilococo aureus

C) Artritis por neisseria gonorrhoeae

D) Artritis reactiva

E) Artritis reumatoídea juvenil

Respuesta D. Diagnóstico: Artritis reactiva (opción D). Oligoartritis migratoria es probablemente una reactiva. En especial si la diarrea fue por Campilobacter.. El trastorno adaptativo es una respuesta psicológica a un evento estresante identificable (gatillante) que no cumple criterios de depresión ni de otro trastorno específico. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clí

1.11.1.003 Artritis reumatoídea

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.6 Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares · Tema 9.7 Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones (MCF, IFP y muñecas) con rigidez matinal >1 hora, de ≥6 semanas; respeta IFD y columna dorsolumbar (excepto C1-C2).
- Anti-CCP: especificidad >95% y predice enfermedad erosiva; FR sensible (75%) pero poco específico (ancianos, VHC, Sjögren, endocarditis). Criterios ACR/EULAR 2010: ≥6 de 10 puntos (articulaciones, serología, VHS/PCR, duración).
- Radiografía: osteopenia yuxtaarticular y erosiones marginales. Extraarticulares: nódulos, Sjögren secundario, escleritis, EPID, pleuritis con glucosa muy baja, Felty; la aterosclerosis acelerada es la principal causa de muerte.
- Manejo inicial: AINE y prednisona en dosis bajas como puente; no usar corticoide en monoterapia. GES: derivación expedita ante poliartritis de manos >6 semanas.
- Seguimiento: derivar a reumatología para metotrexato 15-25 mg una vez por semana + ácido fólico 5 mg semanal (nunca diario), en la ventana de oportunidad (primeras 12 semanas), con meta de remisión.
- Antes de biológicos descartar TBC latente (PPD/IGRA + radiografía) y hepatitis B y C; el metotrexato está contraindicado en embarazo (sulfasalazina e hidroxicloroquina son seguras).

PREGUNTAS (15)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 94

Paciente con dolor articular en MCF e IFP, con rigidez matinal importante. ¿Cuál es el examen específico a solicitar?

A) Factor reumatoide (IgM)
B) ANA y anti-DNA doble cadena
C) Ácido úrico sérico
D) Anticuerpos anti-CCP
E) HLA-B27

Respuesta D. Ante la sospecha clínica de artritis reumatoide (artritis de MCF e IFP con rigidez matinal), el examen con mayor especificidad diagnóstica (> 95-98%) son los anticuerpos anti-péptidos cíclicos citrulinados (anti-CCP). El factor reumatoide es sensible pero inespecífico.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 128

Una paciente de 50 años consulta por artralgias y edema de las manos, especialmente en las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y en las muñecas de ambas manos. Refiere fenómeno de Raynaud y rigidez matinal de 1 hora de duración. Además, relata sensación de arenilla ocular y boca seca. Se solicitan exámenes, que muestran hemograma normal, VHS: 52 mm/h, PCR: 2,8 mg/dl, anticuerpos antinucleares positivos en titulación 1/80, factor reumatoide: 118 UI/ml y anticuerpos anti-CCP: 200 UI/ml. La radiografía de manos muestra osteopenia yuxtarticular de los huesos metacarpianos. **El diagnóstico más probable es:**

A) Lupus eritematoso sistémico
B) Artritis reumatoide
C) Vasculitis primaria
D) Esclerosis sistémica
E) Síndrome de Sjögren primario

Respuesta B. Poliartritis simétrica en manos (MCF, IFP, muñecas) con rigidez matinal de 1 hora, osteopenia yuxtaarticular en radiografía y títulos muy altos de anti-CCP (200 UI/ml) y factor reumatoide confirma Artritis Reumatoide. La presencia de xeroftalmia y xerostomía corresponde a un Síndrome de Sjögren secundario.

Pregunta real · EUNACOM 2017 · Pregunta 21

Mujer de 40 años diagnosticada de artritis reumatoide activa inicia tratamiento con Metotrexato a dosis de 15 mg por semana. ¿Qué fármaco coadyuvante es indispensable prescribir conjuntamente de forma semanal para prevenir toxicidad hematológica, hepática y mucocutánea?

A) Ácido fólico 5 mg semanal administrado 24 a 48 horas post-metotrexato
B) Vitamina B12 1.000 mcg intramuscular mensual
C) Hierro sacarato 200 mg endovenoso trisemanal
D) Carbonato de calcio 1.500 mg diario más colecalciferol
E) Omeprazol 40 mg diario en ayunas de por vida

Respuesta A. El Metotrexato es un antagonista competitivo de la dihidrofolato reductasa. La administración complementaria de Ácido Fólico a dosis de 5 a 10 mg semanales (administrado 24 a 48 horas después del día de toma de metotrexato) es obligatoria, ya que reduce drásticamente los efectos adversos de intolerancia gastrointestinal, estomatitis aftosa, citopenias medulares y elevación de transaminasas sin mermar la eficacia clínica.

Pregunta real · EUNACOM 2019 · Pregunta 08

Hombre de 50 años con artritis reumatoide severa mantiene actividad inflamatoria alta (DAS28 de 5.4) tras 6 meses de tratamiento optimizado con Metotrexato 25 mg/semana más Leflunomida 20 mg/día. Se decide iniciar terapia biológica con Adalimumab (anticuerpo monoclonal anti-TNF alfa). ¿Qué conducta médica es OBLIGATORIA e ineludible antes de administrar la primera dosis del biológico?

A) Realizar artroscopía diagnóstica de rodilla con biopsia sinovial
B) Descartar infección tuberculosa latente mediante PPD o IGRA y radiografía de tórax
C) Administrar vacuna con virus vivos atenuados contra fiebre amarilla
D) Suspender permanentemente el metotrexato 3 meses antes
E) Indicar pulsos de metilprednisolona 1 g EV por 3 días consecutivos

Respuesta B. Los fármacos bloqueadores del TNF-alfa interfieren de forma crítica con la formación y mantenimiento de los granulomas de defensa frente a Mycobacterium tuberculosis. Por ello, antes de iniciar cualquier anti-TNF es estrictamente obligatorio descartar tuberculosis latente mediante PPD (o IGRA) y radiografía de tórax. Si el tamizaje es positivo, debe iniciarse quimioprofilaxis con isoniazida al menos 1 mes antes del biológico.

Pregunta real · EUNACOM 2021 · Pregunta 44

¿Cuál de las siguientes es una CONTRAINDICACIÓN absoluta para el uso de Metotrexato en un paciente con artritis reumatoide recién diagnosticada?

A) Hipertensión arterial controlada con enalapril
B) Embarazo activo o deseo inminente de gestación
C) Osteopenia en densitometría ósea de cadera
D) Presencia de nódulos reumatoideos en olécranon
E) Edad mayor a 55 años

Respuesta B. El Metotrexato es un fármaco con potencial teratogénico y abortivo demostrado (categoría X), por lo que el embarazo activo o el deseo de embarazo en el corto plazo constituyen una contraindicación absoluta para su prescripción en mujeres y hombres en edad reproductiva. Debe suspenderse al menos 3 a 6 meses antes de planificar la concepción, pudiendo utilizarse Sulfasalazina como alternativa segura.

Pregunta real · EUNACOM 2023 · Pregunta 37

Una paciente de 52 años con artritis reumatoide en tratamiento con Metotrexato oral a dosis de 15 mg/semana desde hace 2 meses consulta a control. El examen físico muestra persistencia de 8 articulaciones tumefactas y rigidez matinal de 1 hora. Las transaminasas y el hemograma son estrictamente normales. ¿Cuál es la conducta terapéutica indicada según la estrategia Treat-to-Target?

A) Suspender de inmediato el metotrexato y derivar a cirugía protésica
B) Optimizar la dosis de metotrexato aumentándola a 20 – 25 mg por semana
C) Cambiar el tratamiento a prednisona 60 mg al día en monoterapia
D) Mantener la misma dosis por 2 años antes de evaluar cambios
E) Suspender todo tratamiento inmunosupresor e indicar reposo absoluto

Respuesta B. En la estrategia Treat-to-Target, si a los 2-3 meses de tratamiento inicial con metotrexato el paciente mantiene actividad inflamatoria clínica y los controles de laboratorio (hemograma y transaminasas) demuestran excelente tolerancia biológica, la conducta indicada es optimizar el fármaco escalando la dosis semanal hacia el rango pleno eficaz de 20 a 25 mg/semana (o cambiar a vía subcutánea).

Pregunta de práctica

Mujer de 46 años consulta por 8 semanas de dolor y tumefacción simétrica en articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y muñecas de ambas manos, con rigidez matinal de 90 minutos que dificulta sus labores matutinas. Al examen físico destaca sinovitis activa en 8 articulaciones de las manos, sin compromiso de interfalángicas distales. Sus exámenes muestran VHS de 48 mm/h, PCR de 3,2 mg/dl y anticuerpos anti-CCP fuertemente positivos a títulos de 180 UI/ml (valor de corte 20 UI/ml). Radiografía de manos muestra osteopenia yuxtaarticular. **Según los criterios ACR/EULAR 2010, ¿cuál es el puntaje acumulado y la conducta diagnóstica?**

A) 4 puntos; no cumple criterios, se descarta artritis reumatoide
B) 5 puntos; sospecha intermedia, solicitar resonancia magnética
C) 8 puntos; diagnóstico confirmado de artritis reumatoide
D) 7 puntos; requiere biopsia sinovial obligatoria para confirmación
E) 2 puntos; el cuadro corresponde a artrosis nodal de manos

Respuesta C. La paciente suma 8 puntos en los criterios ACR/EULAR 2010: 3 puntos por 4 a 10 articulaciones pequeñas afectadas + 3 puntos por anti-CCP a títulos altos (> 3 veces el corte) + 1 punto por reactantes elevados (VHS/PCR) + 1 punto por duración ≥ 6 semanas. Con ≥ 6 puntos el diagnóstico de artritis reumatoide es de certeza.

Pregunta de práctica

Mujer de 48 años con diagnóstico reciente de artritis reumatoide seropositiva (anti-CCP fuertemente positivo) consulta para iniciar tratamiento. Presenta sinovitis activa en manos y pies con rigidez matinal de 2 horas. No tiene antecedentes de hepatopatía ni consumo de alcohol, y su hemograma y creatinina son normales. Prueba de embarazo negativa. **¿Cuál es el esquema farmacológico de primera línea más adecuado para iniciar hoy?**

A) Prednisona 20 mg al día en monoterapia permanente
B) Metotrexato 15 mg semanal + Ácido fólico 5 mg semanal + Prednisona 5 mg/día en pauta descendente
C) Infliximab endovenoso cada 8 semanas en monoterapia
D) Celecoxib 200 mg al día como único tratamiento
E) Metotrexato 15 mg al día vía oral + Ácido fólico diario

Respuesta B. El tratamiento de primera línea de la artritis reumatoide recién diagnosticada se basa en el inicio precoz de Metotrexato a dosis de 15 a 25 mg una vez por semana (fármaco ancla), asociado obligatoriamente a Ácido fólico (5 mg semanal) para prevenir toxicidad. Se añade un corticoide a dosis bajas (prednisona ≤ 5-7.5 mg/día) como terapia puente durante las primeras semanas mientras el metotrexato alcanza su efecto pleno. El metotrexato diario (opción E) es un error letal por riesgo de aplasia medular.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 20 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 60 años, con antecedente de hipertensión en tratamiento, con cuadro de tres meses de dolor en ambas manos y muñecas, asociados a rigidez matinal de 2 horas de evolución. Al examen físico se aprecia compromiso en ambas manos de articulaciones metacarpofalángica e interfalangicas proximales. Se solicita radiografía de manos que muestra erosión de la base de la quinta articulación metacarpofalángica. Además se solicita factor reumatoídeo que resulta negativo y péptido citrulinado que también resulta negativo. El diagnóstico más probable es:

A) Artritis reumatoídea
B) Artritis psoriática
C) Osteoartritis
D) Espondilitis anquilosante
E) Lupus con compromiso articular

Respuesta A. Diagnóstico: Artritis reumatoídea (opción A). Es una AR de libro, aunque tenga negativos los marcadores.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 132 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 54 años ha presentado dolores simétricos en pequeñas y grandes articulaciones, con compromiso de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, que iniciaron hace un año, y que se asocian a rigidez matinal de más de una hora y a sensación de arenilla y sequedad ocular. Se solicitan exámenes que muestran PCR: 10, factor reumatoideo: negativo, anticuerpos antinucleares: negativo y anticuerpos anti- CCP negativos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Artritis reumatoidea
B) Artritis reactiva
C) Artrosis
D) Atritis psoriatica.
E) Síndrome de Sjörgren primario

Respuesta A. Diagnóstico: Artritis reumatoidea (opción A). Aunque los marcadores estén negativos, es una AR clásica. Tiene además un Sjögren secundario.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 160 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 50 años, sin antecedentes, presenta cuadro de dos meses de dolor en ambas manos asociados a rigidez matinal de 40 minutos de duración que disminuye con los movimientos. Al examen físico destaca eritema en articulaciones metacarpofalangicas de ambas manos, sin otros síntomas. Se solicita factor reumatoideo que resulta positivo y péptido citrulinado que resulta negativo. El tratamiento de elección para esta enfermedad es:

A) Metotrexato
B) Inmunoglobulina G no específica
C) Antiinflamatorios no esteroidales
D) Corticoides
E) Hidroxicloroquina

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Metotrexato (opción A). Es una AR, aunque tenga negativo el anti-CCP. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 46 · texto original del banco, sin revisar

Mujer con dolor en metacarpofalángicas, IFP y rodillas, con dolor matutino mayor a 1 hora ¿Cuál es el diagnóstico? a. Artritis Reumatoide

A) Hemograma y VHS
B) Ecografía
C) Radiografía
D) TAC con contraste
E) Resonancia magnética

Respuesta A. Diagnóstico: Hemograma y VHS (opción A). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 130 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 45 años consulta por dolores articulares en muñecas, articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales de ambas manos, asociado a dolor en el codo derecho y la rodilla izquierda. Además, se queja de rigidez matinal, que dura cerca de 4 horas. Al examen físico se aprecia aumento de volumen, eritema y aumento de la temperatura local de varias de las articulaciones descritas. ¿Cuál es el examen más específico para el diagnóstico de esta patología?

A) Anticuerpos anti DNA nativo
B) Anticuerpos anti citoplasma de neutrófilos
C) Anticuerpos antinucleares
D) Anticuerpos anti-CCP
E) HLA B27

Respuesta D. Diagnóstico: Anticuerpos anti-CCP (opción D). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 46 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 39 años consulta por deseos de embarazo. Tiene antecedente de artritis reumatoide, en tratamiento con paracetamol. Refiere artralgias de manos con frecuencia. Al examen físico no tiene signos inflamatorios, salvo en una de las articulaciones metacarpofalángicas derechas. Trae factor reumatoideo y anticuerpos antiCCP positivos a títulos elevados y una radiogargía de manos, con lesiones erosivas en algunas articulaciones interfalángicas proximales. ¿Cuál es el tratamiento más indicado en esta paciente?

A) Metotrexato
B) Leflunomide
C) Azulfidine
D) Anticuerpos contra el receptor de TNF alfa
E) Plaquinol

Respuesta D. En la artritis reumatoide activa y erosiva de una paciente que desea embarazo, el metotrexato y el leflunomide están contraindicados por teratogenicidad y se deben suspender antes de concebir. Entre las opciones, el anti-TNF es la alternativa biológica con mejor evidencia de seguridad en la gestación y controla una enfermedad con anti-CCP elevado y erosiones. Es una pregunta de manejo especializad

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 5 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 40 años presenta artralgias y rigidez matinal, que afecta especialmente las muñecas, articulaciones metacarpofalángicas y, desde hace algunos meses, también afecta los tobillos y articulaciones metatarsofalánficas. Al examen tiene artritis de varias a de las articulaciones descritas. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para determinar el curso clínico de la enfermedad?

A) Velocidad de sedimentación hemática
B) Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo
C) Anticuerpos antipéptido citrulinado
D) Proteína C reactiva
E) Anticuerpos antinuclerares

Respuesta C. Los anticuerpos anti péptido citrulinado cíclico, además de ser diagnósticos, se asocian a una enfermedad erosiva y de peor pronóstico en la artritis reumatoide, por lo que sirven para predecir el curso clínico. La velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva reflejan actividad inflamatoria puntual y los anticuerpos antinucleares y ANCA corresponden a otras enfermedades.

1.11.1.004 Artrosis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 9.4 Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada

QUÉ HAY QUE SABER

- Artrosis: degeneración del cartílago con remodelación ósea; dolor mecánico que empeora con el uso y cede con el reposo, rigidez matinal <30 min, crepitación, sin signos inflamatorios.
- Localizaciones: IFD (Heberden), IFP (Bouchard), rizartrosis (1.ª carpometacarpiana), rodilla y cadera (dolor inguinal con pérdida de rotación interna).
- Confirmación: radiografía con carga: pinzamiento asimétrico, esclerosis subcondral, osteofitos y geodas, sin osteopenia ni erosiones; reactantes normales. FR/ANA bajos en ancianos no cambian el diagnóstico.
- Manejo inicial: baja de peso (5-10%), ejercicio y fortalecimiento de cuádriceps, kinesioterapia; paracetamol hasta 3-4 g/día como primera línea.

- Si no basta: AINE tópico u oral breve (con omeprazol); en insuficiencia cardíaca, IRC o úlcera saltar a tramadol. Infiltración con corticoide en brotes.
- Seguimiento completo en APS; derivar a traumatología si el dolor es refractario o incapacitante (artroplastia; GES de endoprótesis de cadera en ≥65 años).

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 121

Una paciente de 64 años consulta por artralgias de las manos, caderas y rodillas. Al examen físico presenta aumento de volumen de las articulaciones interfalángicas, con nódulos de Heberden. Además tiene limitación de los movimientos de las rodillas, con dolor y crepitación articular, sin signos inflamatorios y limitación a la abducción de ambas caderas. **¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?**

A) Prednisona
B) Paracetamol
C) Metotrexato
D) Bifosfonatos
E) Ibuprofeno

Respuesta B. La presencia de nódulos de Heberden, crepitación ósea articular sin calor ni eritema y limitación mecánica confirma artrosis poliarticular. La primera línea de tratamiento analgésico es el paracetamol.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 102

Una paciente de 61 años consulta por dolor articular de ambas manos. Al examen se aprecia aumento de volumen de las articulaciones interfalángicas proximales y distales. Se solicita radiografía de manos, que muestra disminución simétrica del espacio interarticular de las articulaciones interfalángicas, con compromiso de la primera articulación carpometacarpiana bilateral, con presencia de quistes subcondrales. Los ANA y FR resultan positivos. **El diagnóstico más probable es:**

A) Artritis psoriática
B) Artritis reumatoide
C) Artritis reactiva
D) Condrocalcinosis
E) Artrosis

Respuesta E. Compromiso de articulaciones interfalángicas distales (Heberden), proximales (Bouchard) y de la primera carpometacarpiana (rizartrosis), asociado a quistes subcondrales en la radiografía, es patognomónico de artrosis nodal de manos. La positividad a títulos bajos de ANA y FR es un hallazgo inespecífico común en adultos mayores que no debe desviar el diagnóstico clínico.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 95

Paciente con artralgias en IFD e IFP, rigidez matinal de 3-5 minutos, dolor que aumenta con actividad. Radiografía: disminución de espacio articular, esclerosis subcondral y osteofitos. **¿Diagnóstico?**

A) Artritis reumatoide
B) Artrosis
C) Artritis psoriásica
D) Artritis gotosa crónica
E) Espondilitis anquilosante

Respuesta B. Dolor mecánico, que aumenta con la actividad, rigidez matinal muy corta y una radiografía con disminución del espacio articular, esclerosis subcondral y osteofitos: artrosis.

Pregunta de práctica

Mujer de 64 años con sobrepeso consulta por dolor en ambas rodillas de 8 meses de evolución, que empeora al subir escaleras y al caminar distancias largas, aliviando con el reposo. Al examen físico destaca crepitación ósea articular a la flexión de rodillas y presencia de nódulos duros e indoloros en articulaciones interfalángicas distales de ambas manos. Radiografía de rodillas muestra pinzamiento femorotibial medial asimétrico y osteofitos marginales. **¿Cuál es la primera medida farmacológica más adecuada para iniciar su tratamiento?**

A) Prednisona 20 mg al día por vía oral
B) Paracetamol 1 g cada 8 horas por vía oral
C) Metotrexato 15 mg por vía oral una vez a la semana
D) Infiltración intraarticular con ácido hialurónico
E) Celecoxib 200 mg al día de forma permanente

Respuesta B. Cuadro clínico y radiológico clásico de osteoartritis (gonartrosis y nódulos de Heberden en IFD). La primera línea farmacológica según las guías clínicas y el estándar EUNACOM es el paracetamol en dosis de hasta 3-4 g/día, asociado a medidas no farmacológicas como baja de peso y kinesioterapia.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 137 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 63 años presenta dolor en articulaciones de las manos, mayores en las articulaciones interfalángicas distales y proximales, asociadas a rigidez matinal de 5 minutos. Además, refiere dificultades para las actividades que requieren mayor prensión de las manos. Se realiza radiografía de manos, que muestra disminución del espacio articular, con esclerosis subcondral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Artritis reumatoide
B) Artritis psoriática
C) Osteoartritis
D) Osteoporosis
E) Artritis reactiva

Respuesta C. Diagnóstico: Osteoartritis (opción C). A todos, con este video vamos a empezar con el tema de reumatología y los primeros dos temas que vamos a ver son artrosis y la monotítica y aguga, que incluye artítica por cristales y además la artítica y séptica. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

1.11.1.005 Cervicalgia

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 12.15 Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva

QUÉ HAY QUE SABER

- Cervicalgia: dolor de cuello, mecánico en la gran mayoría (posturas, contractura, espondiloartrosis); cervicobraquialgia si irradia al brazo por compromiso radicular.
- Prueba de Spurling (extensión y rotación del cuello hacia el lado afectado) reproduce el dolor radicular; evaluar fuerza, sensibilidad y reflejos del miembro superior.
- Banderas rojas: fiebre, baja de peso, antecedente de cáncer, trauma, déficit neurológico progresivo, signos de mielopatía (marcha, torpeza de manos, Babinski) o AR (inestabilidad C1-C2).
- Sin banderas rojas no se piden imágenes: el diagnóstico es clínico.
- Tratamiento: AINE o paracetamol, calor local, mantener la actividad, educación postural y kinesioterapia; evitar el collarín prolongado. La mayoría mejora en 4-6 semanas.
- Seguimiento completo en APS; RM y derivación si hay banderas rojas, déficit neurológico o falla del tratamiento médico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una mujer de 45 años consulta por dolor cervical de 3 semanas que se irradia al brazo derecho. No tiene fiebre, baja de peso ni debilidad, y el examen neurológico es normal. La prueba de Spurling reproduce el dolor en el brazo. **¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?**

A) Resonancia cervical urgente
B) Antiinflamatorios y kinesioterapia
C) Cirugía cervical
D) Collarín rígido por tiempo prolongado
E) Corticoides orales como primera línea

Respuesta B. Es una cervicobraquialgia, que sigue la misma lógica del lumbago: manejo médico inicial con antiinflamatorios y kinesioterapia. La resonancia se pide solo con signos de alarma, y la cirugía solo si fracasa un tratamiento médico bien llevado o hay déficit neurológico agudo.

1.11.1.006 Columna dolorosa

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 9.16 Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico

QUÉ HAY QUE SABER

- Clasificar el dolor de columna: mecánico (la mayoría; empeora con la carga y mejora con el reposo) versus inflamatorio (espondiloartritis) versus banderas rojas (infección, tumor, fractura, cauda equina).
- Lumbago inflamatorio (ASAS, ≥4 de 5): inicio <45 años, insidioso, >3 meses, mejora con el ejercicio, no con el reposo, dolor nocturno en la segunda mitad de la noche, rigidez matinal >30 min y excelente respuesta a AINE.
- Banderas rojas: edad >50 o <20 años, fiebre, baja de peso, cáncer previo, trauma, dolor nocturno continuo, déficit neurológico, anestesia en silla de montar o alteración esfinteriana.
- Lumbago mecánico sin alarma: AINE o paracetamol, mantenerse activo (no reposo en cama), calor local, kinesioterapia al ceder el dolor; sin imágenes en las primeras 4-6 semanas.
- Sospecha de espondiloartritis: radiografía de pelvis (sacroilíacas), RM STIR si es normal, HLA-B27, AINE en dosis plenas y derivar a reumatología.
- Seguimiento completo en APS del dolor mecánico; reevaluar si persiste >6 semanas.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 26 años consulta por dolor lumbar de 6 meses, de inicio insidioso, que lo despierta en la segunda mitad de la noche y se acompaña de rigidez matinal de 1 hora. **¿Cuál característica adicional apoya más un origen inflamatorio del dolor?**

A) Mejoría con el reposo
B) Inicio súbito tras levantar peso
C) Mejoría con el ejercicio
D) Dolor que aumenta al final del día con la actividad
E) Irradiación por el dermatoma L5 con Lasègue positivo

Respuesta C. El dolor lumbar inflamatorio (criterios ASAS) se caracteriza por inicio antes de los 40 años, comienzo insidioso, duración mayor de 3 meses, dolor nocturno, rigidez matinal prolongada y mejoría con el ejercicio pero no con el reposo. Sugiere espondiloartritis y se estudia con HLA-B27 y resonancia de sacroilíacas. El dolor mecánico empeora con la actividad y mejora con el reposo.

1.11.1.007 Condrocalcinosis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.3 Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)

QUÉ HAY QUE SABER

- Condrocalcinosis (pseudogota): depósito de cristales de pirofosfato de calcio, típica del adulto mayor; monoartritis aguda de rodilla (>50%) o muñeca, gatillada por reposo, cirugía u hospitalización.
- Confirmación: artrocentesis con cristales romboidales de birrefringencia débilmente positiva; el líquido puede superar 100.000 leucocitos y simular infección, por lo que siempre se pide Gram y cultivo (pueden coexistir).
- Radiografía: calcificación lineal de meniscos y del fibrocartílago triangular de la muñeca.

- Buscar causas secundarias en <60 años o formas poliarticulares: hemocromatosis, hiperparatiroidismo, hipomagnesemia, hipofosfatasia.
- Crisis: AINE, colchicina o corticoide intraarticular (descartada la infección); no hay fármaco que disuelva los cristales y el alopurinol no sirve.
- Seguimiento: derivar a reumatología; colchicina profiláctica en crisis recurrentes.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 64

Un paciente de 81 años presenta dolor muy intenso en la rodilla derecha, con EVA 8/10, que le impide caminar. En su examen físico, se aprecia eritema y aumento de volumen de la rodilla. Se solicita radiografía de rodilla, que muestra calcificación meniscal. Además, se realiza punción articular, que da salida a un líquido sinovial, con 160.000 glóbulos blancos por mm³, sin visualización de bacterias y con presencia de cristales con elongación positiva débil. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Artritis séptica
B) Artritis por cristales de pirofosfato de calcio
C) Artritis por cristales de hidroxiapatita de calcio
D) Artritis por oxalato de calcio
E) Gota

Respuesta B. Condrocalcinosis (pseudogota) clásica en paciente anciano: monoartritis de rodilla con calcificación meniscal en la radiografía y líquido sinovial con cristales de birrefringencia positiva débil (elongación positiva). Aunque el recuento leucocitario es descomunal (160.000 GB/mm³), la ausencia de bacterias y los cristales confirman artritis por pirofosfato.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 2

Un paciente de 75 años, es hospitalizado hace 2 días, por un accidente vascular encefálico. Presenta dolor, eritema y aumento de volumen de la rodilla izquierda, con impotencia funcional. Al examen se aprecia eritema y signos de derrame articular. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Artritis séptica
B) Artritis por cristales
C) Artritis reactiva
D) Artritis reumatoide
E) Osteoartritis

Respuesta B. La condrocalcinosis es la causa más frecuente de monoartritis aguda en el adulto mayor y suele desencadenarse por el reposo, como en este paciente hospitalizado. Hay que descartar infección con la punción articular.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 96

Paciente con varios episodios de artritis de rodilla; punción muestra cristales de pirofosfato de calcio intracelulares. **¿Tratamiento para prevenir nuevas crisis?**

A) AINES a demanda
B) Alopurinol
C) Metotrexato oral semanal
D) Infiltración con corticoides
E) Colchicina profiláctica

Respuesta E. Con cristales de pirofosfato de calcio, es una pseudogota recurrente. Para prevenir nuevas crisis se usa colchicina profiláctica; el alopurinol es para el urato.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 132 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 70 años ha presentado 3 episodios de dolor y aumento de volumen de la rodilla derecha, que le impide o dificulta la marcha, pero que ha respondido a analgésicos. Acude nuevamente por los mismos síntomas, objetivándose artritis de rodilla derecha, con signos de derrame articular, por lo que se punciona, dando salida a un líquido articular inflamatorio, con abundantes cristales de pirofosfato de calcio, sin bacterias. ¿Qué fármaco es más adecuado para evitar recurrencias?

A) Colchicina
B) Naproxeno
C) Alopurinol
D) Hidroclorotiazida
E) Metotrexato

Respuesta A. La opción correcta es la A (Colchicina). En este escenario clínico, colchicina se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

1.11.1.008 Epicondilalgia, epitroclealgias

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 12.11 Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Epicondilitis lateral («codo de tenista»): tendinopatía de los extensores (extensor radial corto del carpo) por sobreuso; dolor en la cara lateral del codo que aumenta con la extensión resistida de la muñeca (prueba de Cozen).
- Epitrocleítis («codo de golfista»): dolor en la cara medial del codo que aumenta con la flexión y pronación resistidas de la muñeca.
- Diagnóstico clínico: dolor a la palpación de la inserción, sin eritema ni aumento de volumen (descarta bursitis olecraniana y artritis séptica).
- Manejo inicial: modificar la actividad repetitiva, AINE, frío local, epicondilera (ortesis) y kinesioterapia con ejercicios excéntricos; infiltración con corticoide solo en casos refractarios.
- Seguimiento completo en APS; la mayoría resuelve en semanas a meses. Derivar si persiste >6-12 meses pese al tratamiento.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 42 años, que trabaja en una fábrica de empaque con movimientos repetitivos de la muñeca, consulta por dolor en la cara lateral del codo derecho de 2 meses. Al examen presenta dolor a la palpación del epicóndilo lateral y al extender la muñeca contra resistencia. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Epitrocleítis (codo de golfista)
B) Artritis reumatoide
C) Bursitis olecraneana
D) Síndrome del túnel carpiano
E) Epicondilitis lateral (codo de tenista)

Respuesta E. Dolor en el epicóndilo lateral que aumenta con la extensión resistida de la muñeca (prueba de Cozen) es una epicondilitis lateral, tendinopatía del extensor radial corto del carpo por sobreuso. Se trata con modificación de la actividad, AINE, ortesis y ejercicios excéntricos. La epitrocleítis duele en la cara medial y con la flexión resistida de la muñeca.

1.11.1.009 Esclerosis sistémica progresiva

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.12 Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal · Tema 9.14 Fenómeno de Raynaud Primario vs Secundario y Capilaroscopía Periungueal

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante fenómeno de Raynaud (casi siempre el primer signo) con dedos tumefactos, esclerodactilia, úlceras digitales, reflujo y disfagia, telangiectasias o calcinosis.

- Forma difusa: piel proximal a codos y rodillas y tronco, Raynaud reciente, anti-Scl-70; riesgo de EPID (principal causa de muerte) y crisis renal. Forma limitada (CREST): distal, Raynaud de años, anticentrómero; HAP tardía.
- Raynaud secundario: inicio >30 años, asimétrico, úlceras, ANA positivos y capilaroscopía con megacapilares y áreas avasculares; el primario es simétrico, sin daño, con ANA y capilaroscopía normales.
- Crisis renal esclerodérmica: HTA maligna, falla renal aguda y esquistocitos; captopril oral en dosis crecientes. Evitar prednisona >15 mg/día (la gatilla).
- Manejo inicial: abrigo, dejar el tabaco, evitar betabloqueadores; nifedipino 10-60 mg/día para el Raynaud; omeprazol en dosis doble para el reflujo.
- Seguimiento: derivar a reumatología; espirometría con DLCO y ecocardiograma periódicos; control de presión arterial frecuente en la forma difusa.

PREGUNTAS (9)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 31

Una paciente de 47 años, con antecedente de pirosis y dolor epigástrico de 8 meses de evolución, consulta por disfagia ilógica, de localización alta, que ha ido en aumento. Refiere fenómeno de Raynaud y al examen físico se aprecia esclerodactilia, telangiectasias en el pecho y piel de la cara indurada, sin líneas de expresión. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Acalasia esofágica
B) Esclerosis sistémica
C) Dermatomiositis
D) Lupus eritematoso sistémico
E) Enfermedad mixta del tejido conectivo

Respuesta B. El combo de Raynaud, esclerodactilia, telangiectasias y piel indurada, más un trastorno motor esofágico con pirosis, es un CREST clásico: esclerosis sistémica. La acalasia también da disfagia ilógica, pero no explica el resto del cuadro, que es de la piel y los vasos, no solo del músculo esofágico.

Pregunta real · EUNACOM 2018 · Pregunta 11

Mujer de 50 años con esclerosis sistémica cutánea difusa en tratamiento con prednisona 20 mg al día por sinovitis consulta en urgencias por cefalea pulsátil intensa y mareos. Al examen físico se constata presión arterial de 205/115 mmHg. Los exámenes muestran una creatinina de 2.8 mg/dL (basal de 0.7 mg/dL) y el frotis sanguíneo revela abundantes esquistocitos con plaquetas de 85.000/mm³. ¿Cuál es el tratamiento antihipertensivo de elección indispensable para esta emergencia médica?

A) Nitroprusiato de sodio en infusión continua exclusiva
B) Inhibidor de la Enzima Convertidora de Angiotensina (Captopril oral en dosis crecientes)
C) Metilprednisolona 1 g endovenoso por 3 días
D) Amlodipino asociado a hidroclorotiazida oral
E) Furosemida 80 mg endovenosa en bolo cada 6 horas

Respuesta B. El cuadro corresponde a una Crisis Renal Esclerodérmica (urgencia hipertensiva hiperreninémica con anemia hemolítica microangiopática), gatillada con frecuencia por el uso de corticoides a dosis > 15 mg/día. El tratamiento farmacológico de elección absoluta que detiene la cascada renina-angiotensina y salva la función renal es el inicio inmediato de un IECA de acción corta como Captopril oral a dosis tituladas.

Pregunta real · EUNACOM 2020 · Pregunta 23

Mujer de 45 años con antecedente de fenómeno de Raynaud severo de 10 años de evolución consulta por disfagia a sólidos, pirosis retroesternal y tirantez en la piel de los dedos. Al examen se observa engrosamiento cutáneo circunscrito a dedos de manos y antebrazos distales, calcificaciones subcutáneas periarticulares en pulpejos y telangiectasias faciales. El tronco y muslos presentan piel normal. ¿Cuál es el autoanticuerpo sérico más probablemente positivo en esta paciente?

A) Anticuerpos Anti-Scl-70 (Anti-Topoisomerasa I)
B) Anticuerpos Anticentrómero (ACA)
C) Anticuerpos Anti-dsDNA
D) Anticuerpos Anti-Sm
E) Anticuerpos Anti-Jo-1

Respuesta B. La paciente presenta la clínica clásica del síndrome de CREST (Calcinosis, Raynaud, Esofagopatía, Sclerodactilia, Telangiectasias), que corresponde a la forma cutánea limitada de la esclerosis sistémica (engrosamiento cutáneo restringido a manos/antebrazos distales y cara). El marcador serológico característico, presente en el 70-80% de estos pacientes, son los Anticuerpos Anticentrómero (ACA).

Pregunta real · EUNACOM 2018 · Pregunta 33

Mujer de 38 años consulta por dolor y cambios de coloración trifásicos en los dedos de las manos desencadenados por el frío. Al examen físico se aprecia una pequeña úlcera necrótica dolorosa en el pulpejo del tercer dedo de la mano derecha y pérdida de los pliegues cutáneos dorsales en dedos (esclerodactilia). Los ANA son positivos en dilución 1:320. ¿Qué examen de consultorio o imagen permite evaluar de forma no invasiva la microcirculación periungueal para confirmar conectivopatía?

A) Capilaroscopía periungueal
B) Angiografía por sustracción digital de manos
C) Resonancia magnética nuclear con gadolinio de muñecas
D) Ecografía Doppler carotídea y vertebral bilateral
E) Pletismografía de volumen por pulso arterial

Respuesta A. La capilaroscopía periungueal es la técnica no invasiva estándar de oro para estudiar el fenómeno de Raynaud y descartar esclerosis sistémica precoz. Permite visualizar directamente la morfología de las asas capilares del lecho ungueal, detectando precozmente megacapilares, microhemorragias y áreas avasculares características del patrón esclerodérmico.

Pregunta real · EUNACOM 2020 · Pregunta 47

¿Cuál es el fármaco de primera línea de elección para el tratamiento del fenómeno de Raynaud sintomático recurrente que no responde adecuadamente a las medidas generales de abrigo?

A) Propranolol oral en dosis ascendentes
B) Bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos (Nifedipino oral)
C) Ergotamina combinada con cafeína
D) Prednisona oral a dosis inmunosupresoras
E) Metotrexato subcutáneo semanal

Respuesta B. Los bloqueadores de los canales de calcio dihidropiridínicos (especialmente Nifedipino oral de liberación prolongada a dosis de 10 a 60 mg/día) constituyen el tratamiento farmacológico de primera elección en el fenómeno de Raynaud sintomático. Producen vasodilatación arteriolar periférica disminuyendo la frecuencia e intensidad de los espasmos vasomotores.

Pregunta de práctica

Mujer de 54 años con antecedente de esclerosis sistémica cutánea difusa diagnosticada hace 14 meses (Anti-Scl-70 positivo), en tratamiento con metotrexato y prednisona 20 mg/día por poliartralgias. Es traída a urgencias por cefalea intensa, visión borrosa y ortopnea. Al examen físico se constata PA 210/125 mmHg, FC 98 lpm, fondo de ojo con exudados algodonosos. Piel indurada en brazos y tronco. Exámenes: creatinina plasmática 3.2 mg/dL (basal 0.8 mg/dL hace 1 mes), nitrógeno ureico 55 mg/dL. El frotis sanguíneo evidencia abundantes esquistocitos (3%), plaquetas 82.000/mm³ y LDH marcadamente elevada. **¿Cuál es el diagnóstico de esta emergencia médica, cuál fue el factor desencadenante y qué fármaco es el tratamiento de elección inmediato?**

A) Crisis renal esclerodérmica gatillada por prednisona a dosis alta y tratada con Captopril oral a dosis crecientes
B) Glomerulonefritis postestreptocócica tratada con penicilina benzatina intramuscular
C) Púrpura trombocitopénica trombótica idiopática tratada con plasmaféresis de urgencia exclusiva
D) Nefritis lúpica proliferativa difusa tratada con pulsos de ciclofosfamida endovenosa
E) Estenosis bilateral de arteria renal tratada con angioplastía con balón urgente

Respuesta A. El cuadro clínico corresponde a una Crisis Renal Esclerodérmica clásica: emergencia hipertensiva maligna hiperreninémica con falla renal aguda oligoanúrica y anemia hemolítica microangiopática con esquistocitos. El uso de prednisona en dosis > 15 mg/día fue el factor desencadenante yatrogénico directo. El tratamiento de urgencia indiscutido que salva la función renal y la vida es la administración inmediata de un inhibidor de la ECA, de elección Captopril oral a dosis rápidamente crecientes, suspendiendo los corticoides.

Pregunta de práctica

Mujer de 21 años, estudiante universitaria, consulta por cambios de coloración en los dedos de ambas manos al exponerse al frío invernal. Refiere que los dedos se tornan completamente blancos y fríos, luego azulados y finalmente enrojecidos y calientes al volver a una habitación temperada. Los episodios son simétricos en ambas manos. Al examen físico no se observan úlceras, cicatrices ni esclerodactilia, los pulsos radiales son simétricos y amplios. Los exámenes de laboratorio revelan hemograma, VHS y función renal normales, con anticuerpos antinucleares (ANA) negativos. La capilaroscopía periungueal muestra asas capilares finas y regulares sin dilataciones. **¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y cuál es la indicación inicial de elección?**

A) Fenómeno de Raynaud primario (Enfermedad de Raynaud); educar en medidas de abrigo, evitar exposición al frío y cese de tabaco si corresponde
B) Esclerosis sistémica limitada incipiente; indicar Prednisona 40 mg al día de inmediato
C) Trombangiítis obliterante de Buerger; derivar a cirugía vascular para simpatectomía cervical urgente
D) Lupus eritematoso sistémico; iniciar hidroxicloroquina y aspirina en dosis bajas
E) Fenómeno de Raynaud secundario; iniciar anticoagulación oral con acenocumarol por seis meses

Respuesta A. El cuadro corresponde a un Fenómeno de Raynaud Primario o Enfermedad de Raynaud: mujer joven de 21 años, episodios trifásicos estrictamente simétricos en ambas manos, ausencia total de lesiones tróficas o úlceras, laboratorio con ANA negativos y capilaroscopía periungueal normal. En esta condición benigna el pilar fundamental del manejo son las medidas no farmacológicas de abrigo y educación para evitar desencadenantes.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 45 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 50 años, con antecedente de fenómeno de Raynaud frecuente, desde hace 5 años consulta por edema de los dedos y artritis de algunas articulaciones interfalángicas. Se solicitan exámenes inmunológicos que resultan ANA: positivos 1/320, en patrón anticentrómero; antiDNA: negativos; Anti Sm: negativos; Anti Ro negativo; Anti La: negativo; Factor reumatoide: negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Artritis psoriática
B) Esclerosis sistémica
C) Lupus
D) Enfermedad mixta del tejido conectivo
E) Artritis reumatoide

Respuesta B. Diagnóstico: Esclerosis sistémica (opción B). Es un CREST clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 16 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 47 años consulta por pirosis y regurgitación de dos años de evolución, asociada a disfagia alta intermitente, que ha ido en aumento. Al examen físico, presenta signos vitales normales, se observan telangiectasias en el tórax y esclerosis de la piel de los dedos. Su examen cardiopulmonar y abdominal es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Acalasia esofágica
B) Esclerosis sistémica progresiva
C) Lupus eritematoso sistémico
D) Dermatomiositis
E) Polimiositis

Respuesta B. Esclerosis Sistémica Progresiva (Síndrome de CREST): Este síndrome se caracteriza por calcinosis, fenómeno de Raynaud, compromiso esofágico, esclerodactilia y telangiectasias. A largo plazo, puede desarrollar hipertensión pulmonar. El compromiso esofágico suele presentarse como disfagia ilógica y pirosis.

1.11.1.010 Fibromialgia

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.23 Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS

QUÉ HAY QUE SABER

- Fibromialgia: dolor musculoesquelético crónico generalizado (>3 meses, en 4 cuadrantes) por sensibilización central, con fatiga, sueño no reparador, colon irritable, cefalea y alteraciones cognitivas; más frecuente en mujeres de 20-55 años.
- Examen: hiperalgesia y alodinia a la presión suave, sin artritis, fuerza normal.

- Laboratorio rigurosamente normal (VHS, PCR, hemograma, CK, TSH); pedirlo para descartar hipotiroidismo, polimialgia reumática (VHS alta, >50 años), miopatías y conectivopatías.
- Pilar del tratamiento: educación en neurobiología del dolor y ejercicio aeróbico gradual de bajo impacto (caminata, natación, bicicleta); terapia cognitivo-conductual e higiene del sueño.
- Fármacos: duloxetina, pregabalina o amitriptilina en dosis bajas nocturnas. Corticoides y opioides mayores están contraindicados (ineficaces, hiperalgesia y dependencia).
- Seguimiento: derivar a equipo especializado o salud mental si es refractaria o hay comorbilidad psiquiátrica relevante.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM · Manejo de primera línea en Fibromialgia

Mujer de 36 años consulta por dolores osteomusculares generalizados en extremidades superiores, inferiores y columna de 10 meses de evolución. Refiere insomnio de mantención, sensación de fatiga extrema matinal, colon irritable y cefaleas tensionales frecuentes. Al examen físico no hay artritis, la fuerza muscular es 5/5 simétrica y presenta dolor a la presión suave en múltiples puntos musculotendinosos del cuerpo. La VSG (8 mm/h), la PCR, la TSH, la CPK y los ANA son normales. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea más apropiado?

A) Prednisona 40 mg/día oral por 4 semanas y reposo en cama
B) Educación del dolor, ejercicio aeróbico progresivo de bajo impacto y Duloxetina oral
C) Sulfasalazina 1 g cada 12 horas e infiltración intraarticular con triamcinolona
D) Sulfato de morfina de liberación prolongada y reposo absoluto
E) Celecoxib 200 mg cada 12 horas de forma indefinida

Respuesta B. La paciente cumple criterios de Fibromialgia: dolor musculoesquelético crónico generalizado (> 3 meses en 4 cuadrantes), sueño no reparador, fatiga crónica, síntomas somáticos acompañantes y normalidad estricta de reactantes de fase aguda y enzimas musculares. El pilar fundamental de manejo es la educación, la actividad física aeróbica regular de bajo impacto (caminata, natación, bicicleta) y fármacos neuromoduladores como la Duloxetina (30-60 mg/día) o Pregabalina/Amitriptilina. Los corticoides y opioides están formalmente contraindicados.

Pregunta real · EUNACOM · Contraindicaciones farmacológicas en Fibromialgia

¿Cuál de los siguientes grupos farmacológicos se encuentra FORMALMENTE CONTRAINDICADO en el manejo a largo plazo de la Fibromialgia debido a su total ineficacia para modular el dolor nociplástico y su alto riesgo de inducir hiperalgesia paradójica y dependencia?

A) Inhibidores duales de la recaptura de serotonina y noradrenalina (Duloxetina)
B) Ligandos de la subunidad alfa-2-delta de canales de calcio (Pregabalina)
C) Antidepresivos tricíclicos en dosis bajas (Amitriptilina)
D) Corticoides sistémicos y analgésicos opioides mayores
E) Analgésicos no opioides puros (Paracetamol SOS)

Respuesta D. Tanto las guías clínicas internacionales (EULAR, ACR) como las recomendaciones nacionales contraindican formalmente el uso de corticoides (prednisona) y de opioides mayores en el tratamiento de la fibromialgia. No existe evidencia de eficacia en dolor por sensibilización central, y los opioides inducen hiperalgesia paradójica mediada por receptores NMDA, dependencia física y deterioro cognitivo severo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 50 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 52 años presenta un cuadro de astenia, mialgias y artralgias generalizadas, con debilidad de las extremidades superiores. Refiere que despierta muy cansada, con dolores generalizados que limitan su actividad. Al examen físico presenta movilidad articular normal, con fuerzas conservadas, sin alteraciones sensitivas, ni artritis, pero con dolor a la palpación muscular en múltiples zonas. En sus exámenes presenta hemograma normal, VHS: 12 mm/h, PCR: 0,2 mg/dl, anticuerpos antinucleares positivos, en titulación 1/40, factor reumatoide: 26 UI/ml (VN: < 15 UI/mL) y anticuerpos anti-CCP: 13 UI/L (VN: < 8 UI/L). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar biopsia muscular
B) Indicar pregabalina y ejercicios de estiramiento muscular
C) Iniciar prednisona oral
D) Solicitar perfil ENA (antígenos nucleares extractables)
E) Iniciar metotrexato oral

Respuesta B. El cuadro clínico es una fibromialgia y los marcadores algo elevados no tienen mayor relevancia (recordar que son una trampa).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 179 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 54 años, con antecedente de síndrome de intestino irritable, que presenta un cuadro de astenia, debilidad de las extremidades superiores y mialgias. Además refiere sequedad ocular y cefalea. Al examen físico presenta movilidad articular normal, sin alteraciones de la sensibilidad, ni paresias evidentes. Presenta dolor a la presión de ambos epicóndilos y a la palpación de los músculos de la espalda. En sus exámenes presenta hemograma normal, con anticuerpos antinucleares positivos, en titulación 1/40, con factor reumatoide negativo y anticuerpos contra antígenos nucleares extractables negativos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar hidrocortisona endovenosa y reevaluar en una semana
B) Indicar pregabalina y ejercicios suaves de elongación
C) Iniciar prednisona oral
D) Solicitar biopsia de glándula salival secundaria
E) Iniciar metotrexato y antiinflamatorios no esteroidales

Respuesta B. Era una fibromialgia (mialgias, astenia y dolor a la compresión de las masas musculares, sin otras alteraciones), probablemente en contexto de un trastorno de somatización. El tratamiento es con ejercicios y estabilizadores de la conducción nerviosa. Que los ANA estén positivos, no importa, porque no hay clínica de lupus. Además, están en una titulación baja (1/40), lo que se encuentra hasta en un

1.11.1.011 Hombro doloroso

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 12.15 Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome del manguito rotador (la causa más común): dolor de hombro con movimientos repetitivos, peor de noche y al acostarse sobre él; duele la abducción y elevación; movilidad pasiva conservada.
- Maniobras: arco doloroso entre 60° y 120°, Neer y Hawkins (pinzamiento subacromial) y Jobe (supraespinoso). Debilidad o ascenso de la cabeza humeral sugieren rotura.
- Capsulitis adhesiva (hombro congelado): limitación activa y pasiva, fase dolorosa y luego rigidez; asociada a diabetes; corticoides y kinesioterapia intensiva.
- Descartar dolor referido (cervical, cardíaco, diafragmático) y Pancoast en fumador.
- Diagnóstico clínico; ecografía como examen de elección si se necesita imagen. Manejo: reposo relativo, AINE, frío y kinesioterapia; infiltración subacromial en casos seleccionados.
- Seguimiento completo en APS; derivar a traumatología si hay rotura completa, debilidad o falta de respuesta tras 3-6 meses.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 52 años, pintor, con dolor de hombro derecho de 3 meses que aumenta al levantar el brazo y de noche al dormir sobre ese lado. Al examen presenta arco doloroso entre 60° y 120° de abducción y pruebas de Neer y Hawkins positivas, con fuerza y rango pasivo conservados. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Capsulitis adhesiva
B) Rotura masiva del manguito rotador
C) Síndrome de pinzamiento subacromial (tendinopatía del supraespinoso)
D) Luxación glenohumeral
E) Artrosis acromioclavicular

Respuesta C. Arco doloroso entre 60° y 120°, dolor nocturno y pruebas de Neer y Hawkins positivas, con fuerza y movilidad pasiva conservadas, sugieren pinzamiento subacromial con tendinopatía del supraespinoso. La capsulitis adhesiva limita el rango pasivo y el activo, y una rotura masiva produce debilidad o incapacidad de elevar el brazo.

1.11.1.012 Lumbago infeccioso y tumoral

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.11 Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar lumbago infeccioso o tumoral ante banderas rojas: fiebre, baja de peso, antecedente de cáncer, dolor nocturno o en reposo que no cede, edad >50 años, inmunosupresión, drogas endovenosas, infección reciente (urinaria, endocarditis).

- Espondilodiscitis: dolor a la percusión de la apófisis espinosa, VHS y PCR elevadas; la radiografía se altera tarde (erosión de dos platillos contiguos y del disco). TBC (mal de Pott) en inmunosuprimidos.
- Tumoral: metástasis de mama, pulmón, próstata, riñón y tiroides, o mieloma (anemia, hipercalcemia, lesiones líticas); el tumor típicamente respeta el disco.
- Examen de elección: RM con gadolinio; además hemograma, VHS, PCR, hemocultivos y estudio del primario; biopsia guiada si los cultivos son negativos.
- Urgencia: déficit neurológico o síndrome de cauda equina (anestesia en silla de montar, retención urinaria): derivación inmediata.
- Seguimiento: derivar a especialista (traumatología, infectología u oncología).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 45 años, usuario de drogas endovenosas, presenta dolor lumbar progresivo de 3 semanas, que no cede con el reposo y es peor de noche, con fiebre intermitente. Al examen hay dolor a la percusión de la apófisis espinosa de L3. PCR 120 mg/L, VHS 85 mm/h. **¿Cuál es el examen de elección para el diagnóstico?**
> **A)** Radiografía de columna lumbar
> **B)** Solo analgesia y control en 6 semanas
> **C)** Densitometría ósea
> **D)** Electromiografía
> **E)** Resonancia magnética de columna lumbar con gadolinio
> Respuesta E. Un lumbago con banderas rojas (fiebre, drogas endovenosas, dolor nocturno, reactantes elevados) sugiere espondilodiscitis o absceso epidural. La resonancia con gadolinio es el examen de elección por su sensibilidad precoz; la radiografía se altera tarde. Además se toman hemocultivos y, si son negativos, biopsia. Otras banderas rojas son el antecedente de cáncer y la baja de peso.

1.11.1.013 Lumbago mecánico

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 9.16 Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico

QUÉ HAY QUE SABER

- Lumbago mecánico: la causa más frecuente de dolor lumbar; dolor que empeora con la carga y el movimiento y mejora con el reposo, tras sobreesfuerzo, con contractura paravertebral; asociado a debilidad de la musculatura axial y abdominal.
- Diagnóstico clínico tras descartar banderas rojas (fiebre, cáncer, baja de peso, trauma, edad >50, déficit neurológico, cauda equina). Sin alarma no se piden imágenes.
- Lumbociática: irradia bajo la rodilla con Lasègue positivo; L5 = dorso del pie y ortejo mayor; S1 = planta y borde lateral, con aquiliano disminuido. Mismo manejo médico inicial si no hay déficit progresivo.
- Tratamiento: AINE o paracetamol, calor local, mantenerse activo según tolerancia (el reposo en cama prolonga la incapacidad), reposo laboral breve si es necesario.
- Kinesioterapia y fortalecimiento de la musculatura cuando cede el dolor agudo; educación postural y baja de peso para prevenir recurrencias.
- Seguimiento completo: la mayoría mejora en 4-6 semanas; imágenes y derivación si persiste o aparecen banderas rojas.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM 2017 · Pregunta 14

Hombre de 28 años consulta por lumbago bajo de 4 meses de evolución. ¿Cuál de las siguientes características semiológicas apoya fuertemente el origen INFLAMATORIO del dolor por sobre una etiología mecánica?

A) El dolor aumenta con la deambulación y calma completamente al acostarse en la cama
B) El dolor despierta al paciente en la madrugada y mejora al iniciar la actividad física matinal
C) El dolor inició bruscamente tras levantar una caja pesada en el trabajo
D) La rigidez matinal de la columna dura menos de 10 minutos
E) El dolor empeora con la tos y la maniobra de Valsalva

Respuesta B. El dolor lumbar inflamatorio característico de las espondiloartropatías se define por presentarse en pacientes jóvenes (< 45 años), tener un inicio insidioso crónico, empeorar con el reposo en cama, despertar al paciente en la segunda mitad de la noche y MEJORAR claramente con el ejercicio y el movimiento físico. El dolor que calma con el reposo y aumenta con la carga es típicamente mecánico.

1.11.1.014 Lupus eritematoso sistémico

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.5 Nefropatía Lúpica: Clasificación ISN/RPS y Conducta Terapéutica · Tema 9.8 Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal · Tema 9.9 Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora · Tema 9.10 Lupus Cutáneo (Subagudo y Crónico Discoide) y Lupus Inducido por Drogas

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en mujer joven con eritema malar que respeta surcos nasogenianos, fotosensibilidad, úlceras orales indoloras, artritis no erosiva (Jaccoud), serositis, citopenias, nefritis o convulsiones/psicosis.
- ANA ≥1:80 es criterio de entrada obligatorio (sensibilidad >98%); anti-Sm el más específico (>99%); anti-dsDNA y C3/C4 bajos indican actividad y riesgo de nefritis. Criterios EULAR/ACR 2019: ≥10 puntos.
- Lupus por fármacos (hidralazina, procainamida, isoniazida, anti-TNF): anti-histona positivo, anti-dsDNA negativo, respeta riñón y SNC; se suspende el fármaco. Anti-Ro: lupus subagudo y bloqueo AV congénito.
- Nefritis lúpica: biopsia renal si proteinuria ≥0,5 g/24 h, sedimento activo o caída de la VFG; clases III-IV requieren inducción con pulsos de metilprednisolona + micofenolato o ciclofosfamida.
- Manejo inicial: hidroxicloroquina ≤5 mg/kg/día de por vida en todos (reduce brotes y mortalidad; control oftalmológico) y fotoprotección FPS ≥50; corticoides según actividad.
- Seguimiento: derivar a reumatología (GES); controles con hemograma, función renal, orina, complemento y anti-dsDNA.

PREGUNTAS (9)

Pregunta real · EUNACOM 2024 · Pregunta 17

Mujer de 28 años con diagnóstico reciente de Lupus Eritematoso Sistémico leve manifestado por eritema malar y artralgias sin daño de órgano vital. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico basal que debe indicarse de forma obligatoria e indefinida para reducir brotes y disminuir la mortalidad global?

A) Prednisona 60 mg al día en monoterapia permanente
B) Hidroxicloroquina a dosis menor o igual a 5 mg/kg peso real al día
C) Ciclofosfamida endovenosa mensual por 6 ciclos
D) Metotrexato 25 mg a la semana subcutáneo sin corticoides
E) Ácido acetilsalicílico 100 mg al día exclusivo

Respuesta B. En todo paciente con LES, independientemente de la severidad o si está en remisión clínica, la Hidroxicloroquina (dosis ≤ 5 mg/kg peso real/día) es la piedra angular del tratamiento que debe mantenerse de por vida. Ha demostrado reducir significativamente la frecuencia de brotes, prevenir el daño orgánico renal, disminuir eventos trombóticos y reducir la mortalidad global.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 28

Una mujer de 30 años presenta un cuadro de malestar general y artralgias de varias semanas de evolución, asociado a febrícula ocasional. Al examen físico se aprecia rash facial, úlceras orales, alopecia difusa y artritis de varias articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas de ambas manos. En sus exámenes destaca hematocrito 30%, hemoglobina 10 g/dl, leucocitos 4.000 por mm3 con 15% de linfocitos, ANA positivo en dilución 1:640, anti-DNA de doble hebra positivo en dilución 1:160, C3 60 mg/dl, C4 11 mg/dl, factor reumatoide 65 U/ml y anti-CCP negativo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Artritis reumatoide
B) Púrpura trombocitopénico trombótico
C) Lupus eritematoso sistémico
D) Vasculitis
E) Dermatomiositis

Respuesta C. Rash malar, úlceras orales, alopecia, artritis no erosiva de manos, anemia, leucopenia con linfopenia, ANA y anti-DNA positivos e hipocomplementemia: lupus eritematoso sistémico. El factor reumatoide puede ser positivo en el lupus; el anti-CCP negativo aleja la artritis reumatoide.

Pregunta real · EUNACOM 2018 · Pregunta 39

Hombre de 65 años en tratamiento crónico con Hidralazina por hipertensión arterial refractaria consulta por poliartralgias en manos, astenia y dolor torácico pleurítico de 3 semanas. Los exámenes de laboratorio revelan ANA positivos 1:320 y anticuerpos Anti-Histona positivos en títulos altos. El sedimento de orina es normal sin proteinuria, la función renal es óptima y los anticuerpos Anti-dsDNA son negativos. ¿Cuál es la conducta terapéutica inicial más apropiada?

A) Iniciar pulsos de Ciclofosfamida endovenosa mensual
B) Suspender de inmediato la hidralazina
C) Indicar prednisona 60 mg al día por 2 años sin retirar fármacos
D) Realizar biopsia renal percutánea urgente
E) Prescribir metotrexato subcutáneo a dosis máximas

Respuesta B. El cuadro corresponde a un Lupus Inducido por Drogas secundario a hidralazina, respaldado por la presencia de síntomas sistémicos y articulares con respeto renal, ausencia de anti-dsDNA y presencia característica de anticuerpos anti-histona positivos. La conducta primaria y curativa consiste en la suspensión inmediata del fármaco causante, lo que conduce a la resolución progresiva del cuadro clínico en pocas semanas.

Pregunta real · EUNACOM 2021 · Pregunta 14

Mujer de 32 años embarazada de 18 semanas con diagnóstico de Lupus Cutáneo Subagudo acude a control prenatal. Sus exámenes confirman anticuerpos Anti-Ro (SSA) y Anti-La (SSB) fuertemente positivos. ¿Qué complicación fetal congénita irreversible debe monitorizarse estrictamente mediante ecocardiografía fetal seriada?

A) Tetralogía de Fallot
B) Bloqueo auriculoventricular congénito completo
C) Agenesia renal unilateral
D) Coartación aórtica severa
E) Transposición de grandes vasos

Respuesta B. Los anticuerpos maternos Anti-Ro (SSA) y Anti-La (SSB) de clase IgG atraviesan la barrera placentaria y pueden unirse a las células del sistema de conducción cardíaco fetal en desarrollo, provocando inflamación, necrosis y fibrosis del nodo auriculoventricular. Esto produce un Bloqueo Auriculoventricular Congénito Completo, complicación irreversible que requiere seguimiento ecocardiográfico fetal estrecho y frecuentemente marcapasos definitivo tras el nacimiento.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 74

Una paciente de 28 años consulta por artralgias generalizadas, asociadas a sensación febril y úlceras orales. En sus exámenes destaca creatinina de 1,5 mg/dL, sedimento de orina con hematuria y cilindros hemáticos y hemograma con 4.000 leucocitos por mm³. **¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?**

A) Solicitar factor reumatoide
B) Solicitar radiografía de tórax
C) Solicitar PCR, VHS y creatinfosfoquinasa
D) Solicitar anticuerpos antinucleares
E) Solicitar anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos

Respuesta D. Mujer joven con artralgias, úlceras orales, leucopenia y nefritis (cilindros hemáticos): la sospecha es lupus eritematoso sistémico. El examen de tamizaje es el ANA, sensible en más de 95 %; luego anti-DNA y complemento. Los ANCA orientan a vasculitis, menos probable con úlceras orales y leucopenia.

Pregunta de práctica

Mujer de 24 años consulta por eritema facial en mariposa que respeta surcos nasogenianos tras paseo a la playa, artralgias simétricas en muñecas y manos de 4 semanas y astenia. Al examen físico se confirma eritema malar eritematoso y úlceras orales superficiales indoloras en paladar duro. Hemograma con leucopenia de 3.200 por microlitro y trombocitopenia leve de 110.000. Sedimento de orina y creatinina normales. **¿Cuál es la conducta inicial obligatoria para confirmar el diagnóstico y qué terapia basal innegociable debe recibir?**

A) Solicitar ANA por inmunofluorescencia y prescribir Hidroxicloroquina más fotoprotección estricta
B) Iniciar pulsos de Ciclofosfamida endovenosa de inmediato sin esperar autoanticuerpos
C) Indicar Prednisona 60 mg al día en monoterapia permanente sin exámenes serológicos
D) Solicitar biopsia renal percutánea urgente y derivar a diálisis
E) Prescribir Metotrexato semanal en monoterapia y suspender todo protector solar

Respuesta A. Ante la sospecha clínica de LES, el primer paso diagnóstico indispensable según los criterios EULAR/ACR 2019 es solicitar Anticuerpos Antinucleares (ANA) como criterio de entrada mandatario. En cuanto al tratamiento basal, todo paciente con diagnóstico confirmado o alta sospecha de lupus debe recibir Hidroxicloroquina a dosis ≤ 5 mg/kg peso real/día de forma indefinida, junto a fotoprotección estricta con FPS ≥ 50, medidas que reducen brotes, daño orgánico y mortalidad global.

Pregunta de práctica

Hombre de 68 años con hipertensión arterial en tratamiento con Hidralazina 100 mg cada 12 horas desde hace 9 meses consulta por 4 semanas de astenia, fiebre de 38 grados, artralgias simétricas en muñecas y manos y dolor torácico de tipo pleurítico. Al examen físico se ausculta frote pericárdico leve y sinovitis en muñecas. Exámenes: creatinina 0.9 mg/dL y sedimento de orina completamente normal sin proteinuria. ANA positivos 1:320, anticuerpos Anti-Histona fuertemente positivos, Anti-dsDNA negativo y complemento C3 y C4 normales. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es la conducta médica de elección inmediata?**

A) Lupus inducido por drogas secundario a hidralazina y suspender de inmediato el fármaco
B) Lupus eritematoso sistémico idiopático y hospitalizar para pulsos de ciclofosfamida
C) Endocarditis infecciosa subaguda e iniciar vancomicina con gentamicina
D) Artritis reumatoide seronegativa e iniciar metotrexato semanal
E) Pericarditis tuberculosa e iniciar terapia cuádruple antibacteriana

Respuesta A. El cuadro clínico reúne todos los criterios clásicos de un Lupus Inducido por Drogas por hidralazina: presencia de artralgias, serositis (pleuropericarditis) y síntomas constitucionales, con respeto absoluto de la función renal y ausencia de proteinuria. El perfil inmunológico con anticuerpos Anti-Histona fuertemente positivos (>95%), Anti-dsDNA negativo y niveles normales de complemento es diagnóstico. La conducta terapéutica curativa y de primera línea es la suspensión inmediata de la hidralazina.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 154 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con síndrome nefrótico e hipergammaglobulinemia policlonal, complemento bajo. Diagnóstico:

A) Lupus
B) Amiloidosis
C) Mieloma múltiple
D) Hemograma y VHS
E) Ecografía

Respuesta A. Diagnóstico: Lupus (opción A). El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad del tejido conectivo ANA positiva potencialmente grave. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 98 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 23 años presenta aparición súbita de lesiones eritematosas en las mejillas, que iniciaron luego de exponerse al sol y se asocian a malestar general, caída de cabello y artralgias de manos. En el examen físico destaca eritema malar y edema de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes que muestran hemograma con hemoglobina: 9,8 g/dl, hematocrito 29%, glóbulos blancos: 3500 por mm3 y plaquetas: 90.000 por mm3, más examen de orina con proteinuria +++ y hematuria. ¿Cuál es el examen más sensible para el diagnóstico de la patología descrita?

A) Factor reumatoide
B) Anticuerpos anti-Ro
C) Anticuerpos anti-Sm
D) Anticuerpos antinucleares
E) Anticuerpos antifosfolípidos

Respuesta D. Tiene un lupus eritematoso sistémico. El examen más sensible son los ANA (S = 95%). Los más específicos son los anti-DNA 2h (E = 95%, pero S = 50%; además son indicador de mal pronóstico y de actividad) y los anti-Sm (E = 99%, pero S = 25%).

1.11.1.015 Monoartritis

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.1 Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial · Tema 12.12 Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica

QUÉ HAY QUE SABER

- Monoartritis aguda (<6 semanas, 50% en rodilla): toda monoartritis es séptica hasta demostrar lo contrario. Causas: infección, cristales (gota, pseudogota), debut de artritis inflamatoria, hemartrosis.
- Artrocentesis diagnóstica obligatoria e inaplazable, antes del antibiótico: citoquímico, recuento celular, glucosa, Gram, cultivo y cristales con luz polarizada. Única contraindicación absoluta: celulitis en el sitio de punción.
- Líquido: no inflamatorio 200-2.000 leucocitos (artrosis); inflamatorio 2.000-50.000 (cristales, AR); séptico >50.000 con >90% PMN y glucosa <50% de la plasmática; hemorrágico (trauma, hemofilia).
- Trampas: los cristales no descartan infección (coexisten en ~5%), la pseudogota puede superar 100.000 leucocitos y un Gram negativo no descarta (sensibilidad ~50%).
- Líquido séptico: hospitalizar, hemocultivos, antibiótico EV empírico y drenaje articular. Inflamatorio con cristales: AINE, colchicina o corticoide.
- Seguimiento: derivar a traumatología (séptica) o reumatología (cristales recurrentes o artritis inflamatoria).

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 69

Un paciente de 78 años consulta por gonalgia derecha intensa, que impide la marcha, asociada a aumento de volumen. Al examen físico presenta edema, eritema y aumento de la temperatura local, con signos de derrame articular. **La conducta más adecuada es:**

A) Iniciar antibióticos endovenosos
B) Solicitar factor reumatoide, ANA y ácido úrico
C) Iniciar AINEs
D) Realizar artrocentesis diagnóstica
E) Solicitar resonancia magnética nuclear de rodilla

Respuesta D. En un paciente con monoartritis aguda de rodilla, la artrocentesis diagnóstica es el paso mandatorio inicial. Permite diferenciar entre artritis séptica, artropatía por microcristales (condrocalcinosis en el adulto mayor) o causa mecánica, guiando la conducta inmediata.

1.11.1.016 Oligoartritis

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.19 Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Oligoartritis: compromiso de 2-4 articulaciones. Causas: espondiloartritis (reactiva, psoriásica, enteropática, espondilitis), gonococia diseminada, cristales, artritis séptica, debut de AR o LES.
- Patrón asimétrico de extremidades inferiores con dactilitis o entesitis orienta a espondiloartritis; preguntar por uretritis, diarrea, psoriasis, uveítis y enfermedad inflamatoria intestinal.

- Joven sexualmente activa con fiebre, poliartralgias migratorias, tenosinovitis y pústulas hemorrágicas: gonococia diseminada; cultivar sangre, cuello uterino, recto y faringe; ceftriaxona EV y tratar a la pareja.
- Artrocentesis de la articulación más accesible: recuento, Gram, cultivo y cristales; artritis reactiva tiene líquido inflamatorio estéril.
- Manejo inicial: AINE si se descarta infección; artritis enteropática periférica sigue la actividad intestinal (mejora al tratar el brote).
- Seguimiento: derivar a reumatología para estudio etiológico (HLA-B27, FR, anti-CCP, ANA) y tratamiento de fondo.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 22 años, sexualmente activa sin preservativo, con 4 días de fiebre de 38,4 °C y poliartralgias migratorias, que evoluciona con artritis de la rodilla derecha y la muñeca izquierda, tenosinovitis dorsal de la mano izquierda y 4 pústulas hemorrágicas en las extremidades. La artrocentesis de rodilla muestra 35.000 leucocitos por mm3 con predominio polimorfonuclear y Gram sin bacterias. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y su tratamiento?**
>
> **A)** Artritis reactiva; AINEs
> **B)** Infección gonocócica diseminada; ceftriaxona endovenosa, estudio de otras ITS y tratamiento de la pareja
> **C)** Artritis reumatoide; metotrexato
> **D)** Gota; colchicina
> **E)** Fiebre reumática; penicilina benzatina
>
> Respuesta B. Oligoartritis asimétrica febril en una joven sexualmente activa, con tenosinovitis y pústulas hemorrágicas, es una infección gonocócica diseminada. El Gram y el cultivo del líquido suelen ser negativos; se cultivan sangre, cuello uterino, recto y faringe. Se trata con ceftriaxona endovenosa. La artritis reactiva aparece semanas después y no da pústulas.

1.11.1.017 Osteoporosis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 9.24 Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica

QUÉ HAY QUE SABER

- Osteoporosis: fragilidad ósea por pérdida de masa y microarquitectura; fractura por bajo impacto (caída desde la propia altura) de cadera, vértebra, radio distal o húmero proximal establece el diagnóstico sin necesidad de densitometría.
- Densitometría (DEXA): T-score ≤–2,5 osteoporosis y –1 a –2,5 osteopenia en posmenopáusicas y hombres ≥50 años; Z-score ≤–2 en jóvenes obliga a buscar causas secundarias. FRAX: tratar si fractura mayor ≥20% o cadera ≥3%.
- Descartar causas secundarias: corticoides (la más frecuente), hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, celiaquía, mieloma, hipogonadismo; calcio, fósforo y fosfatasas alcalinas son normales en la osteoporosis.
- Basal: calcio 1.000-1.200 mg/día (preferir dieta), vitamina D3 800-2.000 UI/día (meta ≥30 ng/mL), ejercicio con carga, prevención de caídas, evitar tabaco, alcohol y benzodiacepinas.
- Alendronato 70 mg semanal en ayunas con un vaso de agua, erguido 30-60 min; contraindicado con clearance <35 mL/min (usar denosumab 60 mg SC c/6 meses, sin suspenderlo sin puente). Zoledronato 5 mg EV anual si no tolera VO.
- Seguimiento completo: control clínico y densitometría cada 2 años; derivar en osteoporosis severa con fracturas múltiples (teriparatida).

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 116

Una paciente de 66 años se realiza una densitometría ósea que muestra un T score de -3,5 DS en cadera izquierda y -2,8 en la columna lumbar a la altura de la vértebra L4. Trae además una glicemia, un perfil bioquímico y perfil lipídico, todos dentro de rangos normales. Mide 1,68 metros y pesa 49 kilos. **¿Cuál es la conducta más adecuada para esta paciente?**

A) Indicar calcio y vitamina D vía oral
B) Indicar una carga de vitamina D vía oral
C) Administrar calcitonina intranasal
D) Indicar bifosfonatos vía oral o endovenosa
E) Iniciar terapia de reemplazo hormonal con estrógenos más progestágenos por vía oral

Respuesta D. T-score ≤ -2,5 en cadera y columna: osteoporosis. Tratamiento de primera línea: bifosfonato oral o EV, junto con calcio y vitamina D. Además tiene un IMC bajo (~17), otro factor de riesgo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 173

Paciente femenina con artritis reumatoide, en tratamiento con metrotexate y prednisona desde hace 4 años, es diagnosticada de diabetes mellitus, por lo que se inicia metformina como tratamiento. **¿Que examen es perentorio realizarle, como seguimiento a esta paciente?**

A) Hemograma, con recuento de plaquetas
B) Radiografía atlantoaxoidea
C) Insulinemia
D) LDH
E) Densitometría ósea

Respuesta E. Cuatro años de prednisona más artritis reumatoide: dos factores de osteoporosis secundaria. Todo usuario crónico de corticoides requiere densitometría ósea.

Pregunta real · EUNACOM · Instrucciones de toma del Alendronato

Mujer de 64 años acude a control con densitometría ósea que informa un T-score de -2.8 DE en columna lumbar L1-L4 y -2.6 DE en cuello femoral. No tiene antecedentes de fracturas previas, su clearance de creatinina es de 62 mL/min y no presenta antecedentes digestivos. Se decide iniciar Alendronato 70 mg vía oral semanal. ¿Cuáles son las instrucciones farmacológicas indispensables que deben entregarse a la paciente para garantizar la absorción y prevenir la esofagitis química erosiva?

A) Tomar el comprimido junto con el almuerzo acompañado de un vaso de leche para proteger la mucosa gástrica
B) Tomar el comprimido en ayunas al despertar con un vaso lleno de agua pura, permaneciendo en bipedestación o sentado erguido al menos 30 a 60 minutos sin comer
C) Tomar el comprimido justo antes de acostarse en la cama con jugo de naranja para acidificar el medio gástrico
D) Masticar o disolver el comprimido en agua tibia junto con el suplemento de carbonato de calcio
E) Ingerir el fármaco cada 12 horas con las comidas principales y mantener reposo en decúbito supino por 1 hora

Respuesta B. Los bifosfonatos orales (alendronato, risedronato) presentan una biodisponibilidad oral extremadamente baja (< 1%) y son altamente irritantes para el epitelio esofágico. Para evitar esofagitis erosiva, úlceras esofágicas graves o perforación, y garantizar su absorción, deben ingerirse estrictamente en ayunas al despertar, con un vaso completo de agua corriente pura (sin gas, leche, té ni café), el paciente debe permanecer en posición erguida (de pie o sentado) durante al menos 30 a 60 minutos (prohibido acostarse), y posponer cualquier alimento, bebida o medicamento por al menos una hora.

Pregunta real · EUNACOM · Tratamiento antirresortivo en insuficiencia renal severa

Mujer de 78 años con osteoporosis severa y enfermedad renal crónica avanzada en etapa 4 con una velocidad de filtración glomerular estimada de 22 mL/min presenta alto riesgo de fractura de cadera. Dado que los bifosfonatos están formalmente contraindicados con clearance de creatinina menor a 35 mL/min, ¿cuál es el fármaco antirresortivo de elección aprobado para su uso en falla renal avanzada?

A) Alendronato oral en dosis reducida de 35 mg quincenales
B) Ácido Zoledrónico endovenoso en infusión lenta de 2 horas
C) Denosumab (anticuerpo monoclonal anti-RANKL) 60 mg subcutáneo cada 6 meses
D) Calcitriol oral a dosis suprafisiológicas de 2 mcg al día
E) Ibandronato oral diario sin ayuno

Respuesta C. Denosumab es un anticuerpo monoclonal completamente humano dirigido contra el ligando de RANK (RANKL). A diferencia de los bifosfonatos (que se eliminan por vía renal y son nefrotóxicos con VFG < 30-35 mL/min), el Denosumab se metaboliza por el sistema retículo endotelial como cualquier inmunoglobulina, por lo que no requiere ajuste de dosis ni está contraindicado en insuficiencia renal avanzada. Requiere monitorización estricta de calcemia por riesgo de hipocalcemia.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 148 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 66 años, que mide 1,68 metros y pesa 49 kilos, se realiza una den- sitometría ósea que muestra un T score de -3,5 DS en cadera izquierda y -2,8 en la co- lumna lumbar a la altura de la vértebra L4. Trae además una glicemia, un perfil bioquí- mico y perfil lipídico, todos dentro de rangos normales. ¿Cuál es la conducta más ade- cuada para esta paciente?

A) Indicar calcio y vitamina D vía oral
B) Indicar una carga de vitamina D vía oral
C) Administrar calcitonina endovenosa
D) Indicar bifosfonatos vía oral o endovenosa
E) Iniciar terapia de reemplazo hormonal con estrógenos más progestágenos por vía oral

Respuesta D. Tiene una osteoporosis (T score menor o igual a -2,5), por lo que se debe iniciar bifosfonatos. Sin embargo también tiene que recibir vitamina D y calcio. No debería ha- ber distractores correctos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 121 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 65 años, menopáusica hace 15 años, sufrió una fractura de muñeca derecha hace un año y recientemente sufrió una fractura de cadera derecha. La densitometría ósea muestra un T-score de -3 en la zona lumbar, -2.7 en la cadera derecha y -2.5 en la cadera izquierda. Además de indicar una adecuada ingesta de calcio y vitamina D, ¿cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado?

A) Alendronato 70 mg semanal
B) Risedronato 150 mg semanal
C) Ácido zoledrónico 5 mg cada 6 meses
D) Terapia de reemplazo hormonal
E) Denosumab endovenoso

Respuesta E. Tratamiento de la Osteoporosis: El tratamiento de la osteoporosis generalmente incluye la ingesta de calcio, vitamina D y bifosfonatos. No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los distintos tipos de bifosfonatos, y la principal diferencia entre ellos radica en la periodicidad con la que se administran. El alendronato se administra semanalmente, el ibandronato mensual

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 37 · texto original del banco, sin revisar

¿Cuál es el tratamiento más adecuado para una paciente que se realiza una densitometría ósea con T score de -2,7 en las vértebras lumbares y -2,9 en la cadera izquierda?

A) Bifosfonatos
B) Calcitriol
C) Vitamina D
D) Calcio
E) Raloxifeno

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Bifosfonatos (opción A). Tiene osteoporosis: T score menor a -2,5.. Alternativas: denosumab si contraindicados todos los bifosfonatos; anabólicos si fracturas pese a tratamiento De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

1.11.1.018 Pelviespondilopatías seronegativas

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.16 Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico · Tema 9.17 Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF · Tema 9.18 Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII

QUÉ HAY QUE SABER

- Espondiloartritis seronegativas: espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, reactiva y enteropática; HLA-B27 (>90% en espondilitis), entesitis como lesión primaria, FR y ANA negativos.
- Sospechar ante lumbago inflamatorio en <45 años (nocturno, mejora con ejercicio, rigidez >30 min, dolor glúteo alternante), talalgia por entesitis aquiliana, dactilitis, oligoartritis asimétrica de piernas o uveítis anterior aguda.
- Examen: Schöber modificado <5 cm, expansión torácica <2,5 cm, maniobras sacroilíacas (FABER/Patrick) positivas.
- Estudio: radiografía de pelvis (sacroilitis bilateral, cuadratura vertebral, sindesmofitos, «caña de bambú») y RM STIR en etapas precoces.
- Manejo inicial: AINE en dosis plenas continuas (naproxeno 500 mg c/12 h) y kinesioterapia con ejercicios de extensión; el metotrexato no sirve en el compromiso axial.

- Seguimiento: derivar a reumatología (anti-TNF si falla a 2 AINE, previo descarte de TBC latente y hepatitis); uveítis: derivación urgente a oftalmología.

PREGUNTAS (11)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 72

Un paciente de 39 años, trabajador de la construcción, con IMC de 30, psoriático, consulta por dolor en la zona glútea profunda, de predominio nocturno, muy intenso y que va desapareciendo en la mañana, a medida que realiza sus actividades. El dolor inició hace 3 meses y ha aumentado. Hace 2 meses presentó una uveítis derecha. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Radiculopatía S1
B) Espondiloartritis
C) Espondilodiscitis
D) Hernia del núcleo pulposo con compresión del plexo lumbar
E) Raquiestenosis

Respuesta B. Dolor de predominio nocturno que mejora con la actividad es un dolor inflamatorio, y la uveítis refuerza el diagnóstico: espondiloartritis, con una espondilitis anquilosante clásica.

Pregunta real · EUNACOM 2020 · Pregunta 29

¿Cuál es el antígeno leucocitario humano (HLA) que presenta una asociación genética superior al 90% con la Espondilitis Anquilosante y que se encuentra frecuentemente ligado a las espondiloartritis seronegativas?

A) HLA-DR4
B) HLA-B27
C) HLA-DR3
D) HLA-DQ2
E) HLA-B51

Respuesta B. El alelo HLA-B27 (complejo mayor de histocompatibilidad clase I) presenta una asociación fuertísima con las espondiloartritis seronegativas, encontrándose positivo en más del 90% de los pacientes con Espondilitis Anquilosante y en el 50-80% de las artritis reactivas y espondiloartritis axiales. El HLA-DR4 se asocia a Artritis Reumatoide y el HLA-B51 a Enfermedad de Behçet.

Pregunta real · EUNACOM 2023 · Pregunta 07

Hombre de 24 años consulta por dolor en talón derecho al apoyar el pie en las mañanas y dolor lumbar bajo intermitente que mejora al correr. Al examen físico destaca dolor exquisito a la palpación de la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo derecho, sin signos de infección cutánea. ¿Cuál es el sustrato anatomopatológico primario de esta manifestación periférica típica de las espondiloartritis?

A) Sinovitis proliferativa con formación de pannus erosivo articular
B) Entesitis (inflamación de la inserción ósea del tendón)
C) Tromboflebitis superficial de la vena safena menor
D) Neuroma de Morton interdigital
E) Osteocondritis disecante subastragalina

Respuesta B. La entesitis es la inflamación de las entesis (sitios anatómicos de inserción de tendones, ligamentos, aponeurosis o cápsulas articulares en el hueso). Constituye la lesión elemental primaria y distintiva de las espondiloartritis. La talalgia por entesitis del tendón de Aquiles o de la fascia plantar en el calcáneo es una de las quejas periféricas más típicas en adultos jóvenes.

Pregunta real · EUNACOM 2018 · Pregunta 22

Hombre de 24 años consulta por dolor lumbar de 6 meses de evolución que empeora con el reposo en cama y despierta al paciente en la madrugada, asociado a rigidez matinal de 2 horas. Al examen físico se realiza el Test de Schöber modificado: la distancia inicial de 10 cm entre las marcas de la columna lumbar aumenta únicamente a 12.5 cm a la flexión anterior forzada del tronco. ¿Cómo se interpreta este resultado semiológico?

A) Test normal que descarta patología de columna lumbar
B) Test patológico que indica limitación objetiva de la flexión de la columna lumbar
C) Test patológico que indica hiperlaxitud ligamentosa de columna
D) Test que indica hernia discal lumbar con radiculopatía L5 activa
E) Test no válido que debe repetirse en posición sedente

Respuesta B. En el Test de Schöber modificado, la distancia entre las dos marcas cutáneas lumbares debe incrementarse en al menos 5 cm (alcanzando ≥ 15 cm en total) durante la flexión anterior forzada. Un aumento de solo 2.5 cm (total 12.5 cm) es francamente patológico y demuestra rigidez y limitación objetiva de la movilidad lumbar, hallazgo cardinal en la espondilitis anquilosante.

Pregunta real · EUNACOM 2022 · Pregunta 33

Hombre de 30 años con diagnóstico confirmado de Espondilitis Anquilosante axial severa no presenta mejoría de sus síntomas ni de su rigidez tras 3 meses de tratamiento continuado con Naproxeno 500 mg cada 12 horas y posterior ensayo con Indometacina 75 mg cada 12 horas. Mantiene un índice de actividad BASDAI de 5.8. No tiene compromiso articular periférico. ¿Cuál es el tratamiento de segunda línea indicado para su compromiso axial?

A) Iniciar Metotrexato 20 mg por semana oral con ácido fólico
B) Iniciar Terapia Biológica con un inhibidor del TNF-alfa (ej. Adalimumab o Infliximab)
C) Prescribir Prednisona 40 mg al día de forma permanente
D) Indicar Sulfasalazina 3 gramos al día oral en monoterapia
E) Hidroxicloroquina 400 mg al día más reposo absoluto

Respuesta B. En la Espondilitis Anquilosante con compromiso axial puro refractario a AINEs a dosis plenas, los FARME convencionales sintéticos como Metotrexato o Sulfasalazina han demostrado ser totalmente ineficaces. La indicación formal de segunda línea según las guías internacionales y canasta GES es el inicio de Terapia Biológica con inhibidores del TNF-alfa (o inhibidores de IL-17), previo tamizaje de tuberculosis latente.

Pregunta real · EUNACOM 2024 · Pregunta 29

¿Cuál es el hallazgo radiológico cardinal en la columna vertebral que define la fase avanzada de anquilosis intersomática completa en la Espondilitis Anquilosante?

A) Osteofitos marginales horizontales asimétricos
B) Sindesmofitos óseos verticales delgados que fusionan cuerpos vertebrales en caña de bambú
C) Aplastamientos vertebrales bicóncavos en pez
D) Erosiones líticas expansivas en sacabocado
E) Espondilolistesis ístmica bilateral L5-S1

Respuesta B. En la espondilitis anquilosante avanzada, la osificación progresiva del anillo fibroso del disco intervertebral genera sindesmofitos óseos marginales delgados de orientación estrictamente vertical que unen los cuerpos vertebrales contiguos, produciendo la clásica imagen radiológica de "columna en caña de bambú" (bamboo spine). Los osteofitos de la artrosis son gruesos y horizontales.

Pregunta de práctica

Hombre de 26 años, administrativo, consulta por dolor lumbar bajo y en ambas nalgas de 5 meses de evolución. Refiere que el dolor es mucho más intenso en las mañanas al despertar, acompañado de rigidez de columna que dura más de 1 hora y que le dificulta calzarse los zapatos. El dolor lo despierta a las 4:00 AM, obligándolo a pasear por la habitación. Conforme camina y avanza el día, el dolor disminuye significativamente. Ha tomado Ibuprofeno 400 mg de forma ocasional con alivio casi inmediato de los síntomas. Al examen físico se constata limitación dolorosa de la flexión anterior de tronco y dolor a la palpación de articulaciones sacroilíacas. **¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Lumbago inflamatorio por sospecha de espondiloartritis; indicar AINEs a dosis plenas, solicitar radiografía de pelvis para evaluar sacroilíacas y derivar a reumatología
B) Lumbago mecánico común por discopatía; indicar reposo absoluto en cama por 14 días y relajantes musculares
C) Artritis reumatoide seronegativa; iniciar metotrexato oral 15 mg semanales y solicitar factor reumatoide
D) Espondilodiscitis infecciosa piógena; hospitalizar de inmediato para hemocultivos y resonancia con contraste urgente
E) Fibromialgia primaria; derivar a salud mental y descartar dolor lumbar con radiografía simple

Respuesta A. El paciente cumple todos los criterios de dolor lumbar inflamatorio: edad menor a 45 años (26 años), curso crónico > 3 meses (5 meses), rigidez matinal prolongada (> 1 hora), dolor nocturno que despierta en la madrugada obligándolo a caminar, mejoría franca con el ejercicio, dolor en nalgas (sacroilitis) y excelente respuesta a AINEs. La conducta indicada es mantener AINEs en dosis plenas continuas, solicitar radiografía de pelvis centrada en sacroilíacas y derivar a reumatología.

Pregunta de práctica

Hombre de 25 años consulta por dolor lumbar bajo y rigidez matinal de 90 minutos de 8 meses de evolución, que empeora tras descansar en cama y lo despierta de madrugada. Al examen físico el test de Schöber modificado muestra un aumento de solo 2 cm (de 10 a 12 cm a la flexión anterior forzada) y la expansión torácica es de 2.0 cm. La radiografía de pelvis muestra esclerosis subcondral bilateral simétrica con borramiento parcial del espacio articular en ambas sacroilíacas (sacroilitis bilateral grado 2). El factor reumatoide y los ANA son negativos. **¿Cuál es el diagnóstico clínico definitivo y cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea que debe indicarse de inmediato?**

A) Espondilitis Anquilosante; iniciar AINEs a dosis plenas continuas (ej. Naproxeno 500 mg cada 12 horas) y kinesioterapia de columna
B) Artritis reumatoide seronegativa; iniciar Metotrexato 15 mg semanales más ácido fólico
C) Lumbago mecánico postural; prescribir paracetamol a demanda y reposo en cama por dos semanas
D) Espondilitis Anquilosante refractaria; iniciar Adalimumab subcutáneo sin ensayar AINEs
E) Hernia discal lumbar bilateral; derivar a neurocirugía para laminectomía descompresiva urgente

Respuesta A. El paciente cumple plenamente los Criterios de Nueva York modificados para Espondilitis Anquilosante: criterios clínicos (dolor lumbar inflamatorio crónico, test de Schöber patológico con aumento menor a 5 cm y expansión torácica reducida menor a 2.5 cm) sumado al criterio radiológico mandatorio de sacroilitis bilateral grado ≥ 2 en radiografía simple. El tratamiento farmacológico de primera línea son los AINEs a dosis plenas continuas junto a un programa de kinesioterapia de columna.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 125 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 23 años presenta dolor lumbar, irradiado a ambas piernas, de 2 años de evolución, y que suele ser mayor en la noche. Además presenta dolor torácico, que aumenta con los movimientos respiratorios. El dolor cede parcialmente con AINEs. Refiere un cuadro de artritis de rodilla derecha, autolimitado, hace un año. Al examen físico presenta restricción a los movimientos torácicos y a limitación de la flexión lumbar. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

A) Factor reumatoide
B) Resonancia magnética de articulaciones sacroiliacas
C) TAC de columna lumbosacra
D) Radiografía de tórax
E) Hemograma y VHS

Respuesta B. Es una espondilitis anquilosante. Si bien el mejor examen es la resonancia magnética nuclear de sacroiliacas, se suele pedir una radiografía de sacroiliacas, como primer examen, ya que tiene buen rendimiento en los pacientes con mucho tiempo con síntomas. El FR está negativo. También sirve de apoyo el HLA-B27

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 110 · texto original del banco, sin revisar

Paciente 27 años con espondilopatia o era sacroileítis?'?, cual es el tratamiento inicial:

A) Ibuprofeno
B) Prednisona
C) Paracetamol (porque no puede paracetamol??)
D) Amoxicilina
E) Omeprazol

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Ibuprofeno (opción A). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Prednisona, Paracetamol (porque no puede paracetamol??)) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 97 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 23 años consulta por dolor lumbar y en la zona glútea, de 1 año de evolución, que es mayor en las mañanas y al dormir y que va cediendo a medida que realiza sus actividades durante el día. Además, ha presentado dolor y aumento de volumen de la rodilla derecha, que luego desapareció espontáneamente. Al examen físico tiene placas descamativas en las rodillas, depresiones ungueales, dolor a la compresión prueba de Lasegue negativa, prueba de Schöbber 2 cm. En sus exámenes destaca ANA negativos y factor reumatoide, dentro de límites normales. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

A) Radiografía de columna lumbosacra
B) Tomografía de columna dorsolumbar
C) Radiografía de tórax
D) Resonancia magnética nuclear de articulaciones sacroilíacas
E) ANCA, C3 y C4

Respuesta A. Tiene clínica de una pelviespondiloartropatía (PEA). Además, las lesiones cutáneas orientan fuertemente a artritis psoriática. La RMN es el mejor examen para las PEA, pero La radiografía simple de sacroilíacas (ej. lumbosacra) suele ser el primer examen a solicitar, dado que es barato, está disponible y entrega mucha información. En la artritis psoriática la RMN es muy importante y debe solicitars

1.11.1.019 Poliartritis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.5 Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) y Enfermedad de Still del Adulto · Tema 9.6 Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares

QUÉ HAY QUE SABER

- Poliartritis: inflamación de ≥5 articulaciones. Aguda (<6 semanas): virales (parvovirus B19, rubéola, hepatitis B y C), gonococcia, fiebre reumática, Still. Crónica: AR, LES, artritis psoriásica, gota poliarticular.
- Patrón orienta: simétrica de MCF, IFP y muñecas con rigidez >1 h = AR; IFD con nódulos de Heberden y rigidez breve = artrosis nodal (no inflamatoria); IFD con dactilitis y psoriasis = psoriásica.
- Estudio inicial: hemograma, VHS/PCR, FR, anti-CCP, ANA, ácido úrico, función renal y hepática, orina y radiografía de manos y pies; artrocentesis si hay derrame accesible.
- En <16 años con artritis >6 semanas: artritis idiopática juvenil (GES); la forma oligoarticular con ANA positivos exige control con lámpara de hendidura (uveítis silente). Fiebre en agujas, rash asalmonado y ferritina muy alta: Still.
- Manejo inicial: AINE o paracetamol; evitar corticoides antes de definir el diagnóstico salvo indicación del especialista.
- Seguimiento: derivar a reumatología (GES de AR ante poliartritis de manos >6 semanas).

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Mujer de 32 años, educadora de párvulos, consulta por dolor y aumento de volumen simétrico de muñecas y articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales de ambas manos, de 6 días de evolución, con rigidez matinal y un rash reticular leve en los muslos. Dos semanas antes, varios niños de su sala tuvieron fiebre y las mejillas muy rojas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar metotrexato semanal por sospecha de artritis reumatoide
B) AINEs y control clínico, porque probablemente es una poliartritis viral por parvovirus B19 que se autolimita
C) Prednisona 1 mg/kg/día
D) Cloxacilina endovenosa
E) Alopurinol oral

Respuesta B. Una poliartritis simétrica aguda, de menos de 6 semanas, tras contacto con niños con eritema infeccioso, orienta a parvovirus B19, que suele autolimitarse en semanas. Se maneja con AINEs y observación; la IgM para parvovirus confirma. Iniciar metotrexato es prematuro: antes de 6 semanas una poliartritis puede ser viral y transitoria.

Pregunta de práctica

Mujer de 63 años consulta por dolor en ambas manos de 3 años, que empeora con el uso. Tiene rigidez matinal de 15 minutos. Al examen presenta nódulos duros en las interfalángicas distales y proximales de varios dedos, sin sinovitis de metacarpofalángicas ni de muñecas. La VHS y la PCR son normales. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Artritis reumatoide
B) Artritis psoriásica
C) Artrosis nodal de manos
D) Lupus eritematoso sistémico
E) Gota tofácea

Respuesta C. Compromiso de interfalángicas distales y proximales con nódulos óseos de Heberden y Bouchard, rigidez matinal breve y reactantes normales es artrosis nodal de manos. La artritis reumatoide afecta metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y muñecas, respeta las distales y da rigidez matinal mayor de 1 hora.

1.11.1.020 Polimiositis, dermatomiositis

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.13 Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto

QUÉ HAY QUE SABER

- Miopatía inflamatoria: debilidad proximal simétrica de cinturas (dificultad para subir escaleras, levantarse o peinarse) de semanas-meses, con fuerza distal conservada y respeto de músculos oculares (diferencia con miastenia).
- Dermatomiositis: eritema en heliotropo (párpados violáceos con edema) y pápulas de Gottron en nudillos; polimiositis sin lesiones cutáneas.
- Laboratorio: CK elevada 10-50 veces, transaminasas y LDH de origen muscular; anti-Jo-1 (síndrome antisintetasa: EPID, manos de mecánico, Raynaud). Confirmación con EMG, RM muscular y biopsia.
- Complicaciones: EPID, disfagia orofaríngea (riesgo de aspiración), miocarditis. En adultos (sobre todo >50 años) tamizaje de neoplasia oculta (25-30%): TAC de tórax, abdomen y pelvis, mamografía, evaluación ginecológica y digestiva.
- Diferencial: miopatía por estatinas, hipotiroidismo (TSH), miopatía por cuerpos de inclusión, polimialgia reumática (CK normal).
- Manejo inicial: derivar a reumatología; tratamiento con prednisona 1 mg/kg/día y ahorradores (metotrexato o azatioprina); pulsos o inmunoglobulina si hay disfagia o compromiso respiratorio.

PREGUNTAS (8)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 109

Un paciente de 82 años, con antecedente de diabetes y enfermedad coronaria, en tratamiento farmacológico con metformina 1 gramo cada 8 horas, glibenclamida 10 mg cada 12 horas, aspirina 100 mg al día y atorvastatina 40 mg al día, presenta un cuadro de mialgias generalizadas, asociadas a debilidad muscular, mayor en la cintura escapular y los muslos. Se solicitan exámenes, entre los que destacan CK: 1.320 UI/L, GOT: 128 UI/L y GOT: 133 UI/L. **El diagnóstico más probable es:**

A) Miopatía diabética
B) Polineuropatía diabética
C) Miopatía por estatinas
D) Polimiositis
E) Polimialgia reumática

Respuesta C. Usuario de atorvastatina con mialgias proximales, debilidad y CK elevada varias veces sobre lo normal: miopatía por estatinas (miositis). Exige suspender la estatina.

Pregunta real · EUNACOM 2017 · Pregunta 24

Mujer de 56 años consulta por debilidad proximal en cuatro extremidades y erupción cutánea de 6 semanas. Al examen físico se aprecian pápulas eritematovioláceas sobre las articulaciones metacarpofalángicas de ambas manos (pápulas de Gottron) y coloración violácea en párpados superiores. La CPK plasmática es de 3.800 U/L. Tras iniciar tratamiento con prednisona a dosis plenas, ¿qué estudio médico complementario es INDISPENSABLE y prioritario realizar?

A) Cintigrama óseo para descartar metástasis osteoblásticas difusas
B) Tamizaje exhaustivo de neoplasia oculta mediante TAC toracoabdominal, mamografía y evaluación ginecológica
C) Punción lumbar para estudio citoquímico de líquido cefalorraquídeo
D) Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía urgente
E) Biopsia de médula ósea para descartar mielofibrosis primaria

Respuesta B. En adultos con dermatomiositis (especialmente mayores de 50 años), hasta un 25-30% de los casos corresponden a un síndrome paraneoplásico secundario a un cáncer oculto (cáncer de ovario, mama, pulmón, colon, etc.). Por tanto, además de confirmar la miopatía e iniciar inmunosupresión, es prioritario y mandatorio realizar un cribado oncológico completo e intensivo.

Pregunta real · EUNACOM 2022 · Pregunta 27

Hombre de 48 años con diagnóstico de miopatía inflamatoria presenta debilidad muscular proximal moderada y disnea de esfuerzo progresiva. La radiografía y el TAC de tórax confirman una neumopatía intersticial difusa de patrón reticular bilateral. Al examen destaca fenómeno de Raynaud, artralgias y manos con hiperqueratosis y fisuras descamativas dolorosas en los bordes laterales de los dedos (manos de mecánico). ¿Cuál es el autoanticuerpo sérico más probablemente positivo en este paciente?

A) Anticuerpos Anti-Jo-1 (Anti-histidil-tRNA sintetasa)
B) Anticuerpos Anticentrómero
C) Anticuerpos Anti-Smith
D) Anticuerpos Anti-dsDNA
E) Anticuerpos Anti-Histona

Respuesta A. La constelación clínica de miopatía inflamatoria + enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) + fenómeno de Raynaud + manos de mecánico + artritis no erosiva define el Síndrome Antisintetasa, cuyo marcador serológico patognomónico es el anticuerpo Anti-Jo-1 (anti-tRNA sintetasa).

Pregunta de práctica

Mujer de 58 años sin antecedentes previos consulta por debilidad progresiva en hombros y muslos de 2 meses, con gran dificultad para subir escaleras y peinarse. Al examen físico destaca fuerza 3/5 en cuádriceps y deltoides con fuerza distal 5/5. Los párpados superiores muestran eritema violáceo con edema blando (heliotropo), y en el dorso de las articulaciones metacarpofalángicas de ambas manos se observan pápulas violáceas descamativas (Gottron). La CPK es de 4.200 U/L y las transaminasas están elevadas. **¿Cuál es el diagnóstico clínico, cuál es el tratamiento farmacológico inicial y qué estudio complementario mandatario debe solicitarse?**

A) Dermatomiositis, iniciar Prednisona 1 mg/kg/día y realizar tamizaje exhaustivo de neoplasia oculta
B) Miastenia Gravis, iniciar piridostigmina oral y solicitar anticuerpos anti-MuSK
C) Polimialgia reumática, indicar Prednisona 15 mg al día sin otros exámenes
D) Lupus eritematoso sistémico, iniciar hidroxicloroquina ambulatoria exclusiva
E) Esclerosis lateral amiotrófica, derivar a cuidados paliativos neurológicos

Respuesta A. El cuadro clínico reúne los signos patognomónicos de la Dermatomiositis: debilidad muscular proximal simétrica, elevación masiva de CPK (con transaminasas de origen muscular) y las lesiones cutáneas cardinales: eritema en heliotropo y pápulas de Gottron. El tratamiento de primera línea son los corticoides a dosis plenas (Prednisona 1 mg/kg/día). En una mujer adulta de 58 años es estrictamente obligatorio realizar un tamizaje exhaustivo de neoplasia oculta (TAC de tórax, abdomen y pelvis, mamografía y evaluación ginecológica) debido a que hasta un 30% de los casos corresponden a un síndrome paraneoplásico.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 104 · texto original del banco, sin revisar

Un hombre de 68 años, diabético mal controlado, consulta por mialgias generalizadas de 2 semanas de evolución, mayores en los muslos, asociadas a debilidad, mayor en la cintura pélvica y astenia. En el último tiempo refiere dificultades para ponerse de pie, desde una silla o desde la cama. Al examen físico se objetiva debilidad muscular de predominio proximal, sin alteraciones sensitivas. Se solicitan exámenes, entre los que destacan hemograma con hemoglobina: 12,1 g/dl, hematocrito: 37%, blancos: 7.000 por mm3, plaquetas: 250.000 por mm3, VHS: 10 mm/hora. Además, trae glicemia: 150 mg/dl, creatinfosfoquinasa: 1.760 UI/L, LDH: 1.050 UI/L, PCR: 4,3 mg/L, SGOT: 250 UI/L, SGPT: 170 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Polimiositis
B) Polimialgia reumática
C) Polineuropatía diabética
D) Miopatía por cuerpos de inclusión
E) Síndrome de Guillain Barré

Respuesta A. La debilidad proximal orienta a miopatía. La elevación de la CK y de los parámetros inflamatorios (PCR) orienta a polimiositis. La polimialgia reumática también puede tener una clínica similar e incluso elevar las CK, pero tiende a elevar mucho la VHS (la polimiositis también puede hacerlo) y, lo más importante, no tiene debilidad en el examen físico (aunque sí puede tener sensación de debilidad).

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 105 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 71 años, con antecedente de diabetes, hipertensión arterial y lumbago crónico, en tratamiento con hipoglicemiantes orales, atorvastatina y losartán, presenta un cuadro de 1 mes de debilidad de las 4 extremidades, mayor en los muslos, asociadas a mialgias, que en el último tiempo le han dificultado la marcha. Al examen físico se constata paresia M4 de ambas extremidades inferiores, mayor en los cuádriceps, sin alteraciones sensitivas ni focalidad neurológica. Se solicitan exámenes que muestran hemoglobina: 12,1 g/dl, hematocrito: 33%, blancos: 6.200 por mm3, plaquetas: 180.000 por mm3, VHS: 50 mm/hora, SGOT: 210 UI/L, SGPT: 110 UI/L, CPK: 3.760 UI/L, LDH: 1.050 UI/L, PCR: 4,3 mg/L y hemoglobina glicosilada: 7,5%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Miopatía por estatinas
B) Polimialgia reumática
C) Polimiositis
D) Miositis por cuerpos de inclusión
E) Raquiestenosis medular

Respuesta C. Diagnóstico: Polimiositis (opción C). Es otra polimiositis clásica, en especial por el marcado aumento de las CPK y la debilidad.. La polimiositis y dermatomiositis son miopatías autoinmunes. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 104 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 58 años, con antecedente de cáncer de mama, tratado con cirugía y radioterapia hace un año, consulta astenia y debilidad de las 4 extremidades. Al exa- men físico presenta edema y eritema palpebral, asociado a aumento de volumen en el brazo derecho. Al examen neurológico se constata la tetraparesia, con reflejos osteoten- díneos normales, sin alteraciones en el tono muscular, ni signos focales. El diagnóstico más probable es:

A) Síndrome de Guillain Barré
B) Miastenia gravis
C) Polimialgia reumática
D) Dermatomiosistis
E) Vasculitis

Respuesta D. Es una dermatomiositis clásica: compromiso de párpados, mialgias, debilidad. Re- cordar que suele ser paraneoplásica, por lo que además se debe sospechar recidiva del cáncer.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 131 · texto original del banco, sin revisar

Un hombre de 78 años consulta por debilidad de las extremidades inferiores, que le dificulta realizar movimientos como pararse de una silla o subir escaleras. Al examen físico tiene paresia de las extremidades inferiores, la sensibilidad es normal y no tiene alteración de los reflejos osteotendíneos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Polimiositis
B) Hipotiroidismo
C) Déficit de vitamina B12
D) Distrofia muscular progresiva
E) Raquiestenosis

Respuesta A. Tiene clínica de una miopatía: debilidad proximal, sin alteraciones sensitivas ni de los reflejos. B, C y E afectan los reflejos y tienen otros síntomas. La raquiestenosis principalmente tiene dolor al caminar, más afectación de las raíces comprometidas. D afecta más a niños, ya que es genética.

1.11.1.021 Síndrome antifosfolípidos

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.23 Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo · Tema 9.11 Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante trombosis venosa o arterial en joven sin factores de riesgo, trombosis recurrente o en sitios atípicos, y morbilidad obstétrica: ≥3 abortos consecutivos <10 semanas, muerte fetal ≥10 semanas o parto <34 semanas por preeclampsia o insuficiencia placentaria.
- Pistas de laboratorio: TTPA prolongado que no corrige con plasma normal (anticoagulante lúpico, paradójicamente protrombótico), VDRL falso positivo, trombocitopenia leve; livedo reticularis y endocarditis de Libman-Sacks.
- Diagnóstico: anticoagulante lúpico, anticardiolipinas o anti-β2-glicoproteína I positivos en 2 determinaciones separadas por ≥12 semanas; puede asociarse a LES.
- Trombosis: heparina y luego acenocumarol o warfarina con INR 2-3 de por vida; los anticoagulantes orales directos están contraindicados.
- Embarazo: aspirina 100 mg/día + enoxaparina profiláctica (dosis terapéutica si hubo trombosis); cumarínicos contraindicados (teratógenos). Evitar anticonceptivos con estrógenos y tabaco.
- Seguimiento: derivar a reumatología o hematología; el SAF catastrófico (≥3 órganos en <1 semana) es manejo de UCI.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM 2017 · Pregunta 41

Mujer de 31 años con antecedente de trombosis venosa profunda iliofemoral derecha hace 2 años y dos pérdidas reproductivas previas es diagnosticada de Síndrome Antifosfolípido con triple positividad serológica (anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y anti-beta-2-glicoproteína I positivos confirmados). Actualmente consulta a control hematológico. ¿Cuál es el tratamiento antitrombótico a largo plazo recomendado?

A) Rivaroxabán 20 mg al día oral en monoterapia
B) Antagonistas de vitamina K (Acenocumarol o Warfarina) con meta de INR entre 2.0 y 3.0 indefinido
C) Ácido acetilsalicílico 100 mg al día en monoterapia
D) Apixabán 5 mg cada 12 horas por 6 meses y suspender
E) Dabigatrán 150 mg cada 12 horas asociado a clopidogrel

Respuesta B. En pacientes con Síndrome Antifosfolípido trombótico (y en especial con triple positividad serológica), el tratamiento estándar de oro a largo plazo es la anticoagulación oral indefinida con antagonistas de vitamina K (Acenocumarol o Warfarina) con meta de INR entre 2.0 y 3.0. Los anticoagulantes orales directos (DOACs como rivaroxabán o apixabán) están formalmente contraindicados debido al ensayo TRAPS, que demostró un incremento inaceptable de trombosis arteriales recurrentes.

Pregunta real · EUNACOM 2019 · Pregunta 27

Mujer de 30 años con antecedente de dos abortos espontáneos tempranos y una muerte fetal intrauterina a las 24 semanas presenta confirmación de Síndrome Antifosfolípido mediante anticardiolipinas IgG positivas a títulos altos en dos determinaciones separadas por 14 semanas. Actualmente consulta con 6 semanas de gestación confirmada. No tiene antecedentes de trombosis venosa ni arterial. ¿Cuál es el esquema farmacológico indicado para el manejo de su embarazo?

A) Warfarina ajustada a INR 2.0 – 3.0 durante todo el embarazo
B) Ácido acetilsalicílico 100 mg al día más Enoxaparina 40 mg al día subcutánea
C) Prednisona 40 mg al día vía oral sin anticoagulantes
D) Reposo absoluto en cama sin fármacos antitrombóticos
E) Inmunoglobulina endovenosa mensual exclusiva

Respuesta B. En el Síndrome Antifosfolípido obstétrico (sin antecedente de trombosis vascular previa), el esquema terapéutico estándar para asegurar la viabilidad gestacional y prevenir la pérdida fetal es la combinación sinérgica de Ácido Acetilsalicílico a dosis bajas (100 mg/día) asociado a Heparina de Bajo Peso Molecular a dosis profiláctica (Enoxaparina 40 mg/día SC), manteniéndose la heparina hasta 6 semanas postparto. La warfarina está contraindicada en la gestación por teratogenia.

Pregunta real · EUNACOM 2024 · Pregunta 36

¿Cuál de los siguientes criterios obstétricos clasifica formalmente como criterio clínico para Síndrome Antifosfolípido según los criterios internacionales de Sydney?

A) Un único aborto espontáneo a las 6 semanas de gestación
B) Una muerte fetal inexplicable de feto morfológicamente normal a las 22 semanas
C) Parto prematuro a las 36 semanas secundario a rotura prematura de membranas
D) Dos pérdidas gestacionales del primer trimestre no consecutivas
E) Embarazo ectópico tubario intervenido quirúrgicamente

Respuesta B. Los criterios de Sydney definen tres escenarios de morbilidad obstétrica en SAF: 1) Una o más muertes inexplicables de fetos morfológicamente normales a partir de las 10 semanas de gestación; 2) Uno o más partos prematuros de neonatos normales antes de las 34 semanas debido a preeclampsia severa, eclampsia o insuficiencia placentaria; y 3) Tres o más abortos espontáneos consecutivos inexplicados antes de las 10 semanas.

Pregunta de práctica

Mujer de 29 años, cursando embarazo de 8 semanas confirmado por ecografía con embrión vivo y latidos cardiofetales presentes. Sus antecedentes revelan 3 abortos espontáneos consecutivos del primer trimestre (a las 7, 8 y 9 semanas) en los últimos 3 años, sin antecedentes de trombosis vascular. El estudio inmunológico solicitado hace 3 meses mostró Anticoagulante Lúpico positivo y anticuerpos anticardiolipina IgG en 58 GPL (positivo alto). Se repitieron los exámenes a las 14 semanas de intervalo, confirmándose la positividad persistente de ambos marcadores. **¿Cuál es el esquema farmacológico indicado para asegurar la viabilidad gestacional y prevenir la pérdida fetal?**

A) Ácido acetilsalicílico 100 mg al día más Enoxaparina 40 mg al día subcutánea
B) Warfarina oral ajustada a INR entre 2.0 y 3.0 durante todo el embarazo
C) Rivaroxabán 20 mg al día oral en monoterapia
D) Prednisona 40 mg al día vía oral sin heparina
E) Reposo absoluto en cama sin fármacos antitrombóticos

Respuesta A. La paciente cumple los criterios clasificatorios de Sydney para Síndrome Antifosfolípido Obstétrico: criterio clínico (≥ 3 abortos consecutivos < 10 semanas) más criterio serológico confirmado en dos ocasiones con intervalo > 12 semanas (anticoagulante lúpico y anticardiolipinas IgG a títulos altos). El esquema estándar de elección consiste en la asociación de Ácido Acetilsalicílico a dosis bajas (100 mg/día) más Heparina de Bajo Peso Molecular a dosis profiláctica (Enoxaparina 40 mg/día SC), manteniéndose la HBPM hasta 6 semanas postparto. La warfarina está contraindicada por teratogenicidad.

Pregunta de práctica

Mujer de 31 años con trombosis venosa profunda iliofemoral izquierda no provocada, confirmada por eco-Doppler. Antecedente de dos pérdidas fetales a las 18 y 22 semanas, con fetos morfológicamente normales, y un aborto a las 8 semanas. No usa anticonceptivos, no ha viajado ni tenido cirugías. TP normal, TTPK 52 s (control 30 s) que no corrige con la mezcla 1:1. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Heparina de bajo peso molecular y rivaroxabán como anticoagulante de mantención
B) Medir proteína C, S y antitrombina hoy, antes de anticoagular
C) HBPM con puente a acenocumarol (INR 2–3) y anticuerpos antifosfolípidos, a repetir en 12 semanas
D) Plasma fresco congelado para corregir el TTPK antes de anticoagular
E) Estudio de factores VIII y IX por sospecha de hemofilia

Respuesta C. Trombosis no provocada + muertes fetales desde la semana 10 + TTPK largo que no corrige con mezcla: anticoagulante lúpico y alta sospecha de SAF. Se anticoagula con HBPM puenteada a acenocumarol (INR 2–3) y se piden anticoagulante lúpico, anticardiolipina y anti-β2GP1, a confirmar a las 12 semanas. Los DOAC están contraindicados; el estudio funcional no se hace en fase aguda.

1.11.1.022 Síndrome de Sjögren

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.15 Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC)

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante síndrome sicca: xeroftalmia (arenilla, ardor) y xerostomía (necesidad de líquidos para tragar, caries cervicales), con aumento parotídeo; más frecuente en mujeres de mediana edad. Puede ser primario o secundario a AR o LES.
- Confirmación: test de Schirmer <5 mm en 5 minutos, anti-Ro (SSA) y anti-La (SSB), ANA y FR positivos; biopsia de glándula salival menor (≥1 foco linfocitario/4 mm²) como patrón de oro.
- Extraglandulares: poliartritis no erosiva, acidosis tubular renal distal (hipokalemia), neuropatía, vasculitis; anti-Ro en embarazo: riesgo de bloqueo AV congénito.
- Riesgo de linfoma no Hodgkin B tipo MALT (~40 veces): alarma ante parótida unilateral dura y persistente, púrpura, crioglobulinemia, C4 bajo, adenopatías.
- Manejo inicial: lágrimas artificiales sin preservantes, sustitutos salivales, pilocarpina si hay reserva glandular, higiene dental estricta y control odontológico; evitar anticolinérgicos.
- Seguimiento: derivar a reumatología para confirmar y vigilar complicaciones.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM 2018 · Pregunta 08

Mujer de 52 años consulta por sensación de cuerpo extraño ocular persistente y boca seca de 8 meses. Al examen se observa hiperemia conjuntival bilateral y caries cervicales múltiples. El test de Schirmer arroja 3 mm en 5 minutos en ojo derecho y 2 mm en ojo izquierdo. Los anticuerpos Anti-Ro (SSA) son positivos. ¿Cuál es la complicación neoplásica hematológica que presenta un riesgo incrementado de hasta 40 veces en esta patología?

A) Leucemia mieloide aguda
B) Linfoma No Hodgkin de células B (tipo MALT)
C) Mieloma múltiple de cadenas pesadas
D) Enfermedad de Hodgkin esclerosante nodular
E) Carcinoma epidermoide de labio inferior

Respuesta B. Los pacientes con Síndrome de Sjögren primario tienen un riesgo relativo hasta 40 veces superior al de la población general de desarrollar Linfoma No Hodgkin de células B, especialmente del subtipo de tejido linfoide asociado a mucosas (Linfoma MALT) con asiento en glándulas salivales mayores (parótidas) o tracto digestivo.

Pregunta de práctica

Mujer de 48 años consulta por sensación constante de arenilla en ambos ojos y ardor ocular que le dificulta leer y usar pantallas, de 1 año de evolución. Además refiere boca seca que la obliga a levantarse por las noches a beber agua y necesidad de líquidos abundantes para deglutir alimentos secos como pan o galletas. Su odontólogo le ha tratado 5 caries en el cuello de las piezas dentarias en los últimos 6 meses. Al examen físico se palpa aumento de volumen indoloro y blando de ambas glándulas parótidas. El test de Schirmer muestra un lagrimeo de 2 mm en 5 minutos en ambos ojos. Los exámenes revelan ANA positivos 1:320 y anticuerpos Anti-Ro (SSA) fuertemente positivos. **¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y cuál es el pilar del tratamiento sintomático inicial?**

A) Síndrome de Sjögren primario; indicar lágrimas artificiales sin preservantes, lubricantes salivales y medidas de higiene oral estricta
B) Lupus eritematoso sistémico; iniciar pulsos de ciclofosfamida endovenosa urgente
C) Sarcoidosis sistémica; iniciar prednisona oral 1 mg/kg/día por seis meses
D) Amiloidosis primaria; programar biopsia de grasa subcutánea periumbilical
E) Artritis reumatoide seronegativa; iniciar metotrexato subcutáneo inmediato

Respuesta A. El cuadro clínico reúne todos los criterios del Síndrome de Sjögren primario: queratoconjuntivitis seca sintomática y objetivada por Test de Schirmer patológico (< 5 mm en 5 minutos), xerostomía severa con caries rampantes de cuello, hipertrofia parotídea bilateral indolora y presencia de autoanticuerpos Anti-Ro (SSA) positivos. El tratamiento inicial de las manifestaciones sicca es el reemplazo tópico con lágrimas artificiales, lubricación salival constante, pilocarpina oral si hay reserva glandular e higiene odontológica rigurosa.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 126 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 43 años presenta sequedad bucal, asociada a ardor y sensación de arenilla ocular y a artralgias. Al examen físico tiene sequedad de piel y de mucosas, se observa aumento de volumen de ambas parótidas y se palpan adenopatías submandibulares de consistencia aumentada. Se solicitan exámenes, que muestra FR: 40 UI/nl, ANA positivos 1/16, ENA negativo, antiDNA negativo. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio diagnóstico?

A) Punción parotidea
B) Biopsia ganglionar
C) Anticuerpos anti-CCP
D) Biopsia de glándula salival accesoria
E) Anticuerpos anti-Sm

Respuesta D. La historia es compatible con un síndrome de Sjögren (tiene el síndrome de Sicca: xeroftalmia y xerostomía). El 90% tiene FR positivo. Además, es frecuente que tengan positivos los ANA, con un perfil ENA que muestra anticuerpos anti-Ro o anti-La positivos. Se confirma la biopsia de glándula salival menor o con los anticuerpos anti-Ro o anti-La, aunque actualmente el diagnóstico se realiza en base

1.11.1.023 Síndrome de túnel carpiano

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.19 Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Compresión del nervio mediano bajo el retináculo flexor: parestesias del pulgar, índice y medio, de predominio nocturno, que despiertan y ceden al sacudir la mano (signo de Flick).
- Factores: mujer, embarazo, diabetes, hipotiroidismo, AR, obesidad, trabajo con movimientos repetitivos de muñeca (posible enfermedad profesional).
- Examen: Phalen (flexión de muñecas 60 s) y Tinel positivos; atrofia tenar y debilidad de la abducción del pulgar indican severidad. Pedir TSH y glicemia.
- Confirmación con electromiografía y velocidad de conducción, obligatoria antes de la cirugía y en casos dudosos (diferencial con radiculopatía C6-C7 o polineuropatía).
- Manejo inicial (leve-moderado): férula nocturna con muñeca en posición neutra por 4-8 semanas, modificación de la actividad, tratar la causa; infiltración con corticoide; en el embarazo suele resolver tras el parto.
- Seguimiento: derivar a cirugía (liberación del túnel carpiano) si hay atrofia tenar, déficit motor o sensitivo persistente o refractariedad al tratamiento conservador.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 48 años, costurera, con 4 meses de parestesias en pulgar, índice y dedo medio derechos, que la despiertan en la noche y mejoran al sacudir la mano. Examen: signos de Phalen y Tinel positivos en la muñeca derecha, fuerza conservada y sin atrofia de la eminencia tenar. TSH y glicemia normales. **¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?**

A) Liberación quirúrgica del túnel carpiano de inmediato
B) Resonancia magnética de columna cervical
C) Prednisona 60 mg/día por 2 semanas
D) Férula nocturna de muñeca en posición neutra y modificación de actividades
E) Gabapentina en dosis altas como único tratamiento

Respuesta D. Túnel carpiano leve a moderado (síntomas sensitivos, sin déficit motor ni atrofia tenar): manejo conservador con férula nocturna en posición neutra, pausas y modificación de la actividad; puede agregarse infiltración con corticoide. La cirugía se indica si hay atrofia o debilidad tenar, denervación en la electromiografía o falla del tratamiento conservador.

1.11.1.024 Tendonitis y bursitis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 12.11 Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Tendinitis: dolor al palpar y estirar o contraer contra resistencia el tendón comprometido, por sobreuso. De Quervain (borde radial de la muñeca, Finkelstein positivo), pata de ganso (anteromedial de rodilla), rotuliana, banda iliotibial (lateral de rodilla en corredores), Aquiles, manguito rotador.
- Bursitis: aumento de volumen superficial, visible y fluctuante, con eritema: olecraniana (punta del codo), prepatelar, trocantérica (dolor lateral de cadera al dormir sobre ese lado, obesas).
- Diferenciar de artritis séptica: en la bursitis la movilidad articular pasiva es libre; en la artritis duele todo el rango de movimiento. Bursitis con fiebre o celulitis: puncionar para Gram y cultivo (bursitis séptica, S. aureus).
- Tratamiento: reposo relativo y modificación de la actividad, AINE, frío local, ortesis (férula en De Quervain) y kinesioterapia.
- Infiltración con corticoide en casos refractarios (no en el tendón de Aquiles por riesgo de rotura).
- Seguimiento completo en APS; evaluar origen laboral (Ley 16.744) y derivar si no mejora en 6-12 semanas.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Un obrero de 50 años consulta por aumento de volumen en la punta del codo derecho, de una semana, con eritema local y dolor leve. Mueve el codo en todo su rango sin dolor y no tiene fiebre. No hay derrame articular profundo. **¿Cuál es el diagnóstico y el manejo inicial?**

A) Artritis séptica de codo; punción articular y antibióticos
B) Bursitis olecraniana; AINE y frío local
C) Epicondilitis lateral; epicondilera
D) Gota de codo; alopurinol
E) Bursitis olecraniana; cirugía inmediata

Respuesta B. Un aumento de volumen visible en la punta del codo, con eritema, superficial y con movilidad conservada, es una bursitis olecraniana. Se trata con AINE y frío local; los corticoides quedan para los casos refractarios. La artritis séptica tiene derrame profundo y limitación dolorosa de todo el rango de movimiento.

Pregunta de práctica

Mujer de 35 años, tenista amateur, consulta por dolor en la cara lateral del codo derecho de dos meses de evolución, que aumenta al extender la muñeca contra resistencia. No hay eritema ni aumento de volumen articular. **¿Cuál es el diagnóstico y el manejo inicial correcto?**

A) Bursitis del olécranon: AINE más calor local
B) Epitrocleitis o codo del golfista: reposo, AINE y epicondilera
C) Artritis séptica de codo: punción articular urgente y antibióticos
D) Epicondilitis lateral o codo del tenista: reposo, AINE, epicondilera y kinesioterapia
E) Tendinitis del manguito rotador: ecografía de hombro y corticoides

Respuesta D. La epicondilitis lateral afecta la inserción de los extensores del antebrazo en el epicóndilo. Da dolor en la cara lateral del codo que aumenta con la extensión de la muñeca contra resistencia, y es frecuente en tenistas. Se trata con reposo relativo, AINE, kinesioterapia y epicondilera. No hay eritema ni aumento de volumen, lo que descarta bursitis y artritis séptica.

1.11.1.025 Vasculitis sistémicas

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.4 Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA · Tema 9.20 Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis · Tema 9.21 Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu · Tema 9.22 Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)

QUÉ HAY QUE SABER

- Clasificar por tamaño de vaso: grandes (arteritis de células gigantes en >50 años; Takayasu en mujeres jóvenes con asimetría de pulsos y soplos), medianos (poliarteritis nodosa, Kawasaki) y pequeños (ANCA: GPA, PAM, EGPA; IgA/Henoch-Schönlein); Behçet de vaso variable.
- Sospechar ante síntomas constitucionales con VHS/PCR altas más púrpura palpable, mononeuritis múltiple, glomerulonefritis (hematuria dismórfica, cilindros), hemorragia alveolar, sinusitis destructiva o nódulos pulmonares cavitados.
- Arteritis temporal (cefalea nueva, claudicación mandibular, amaurosis, VHS >50): iniciar prednisona 1 mg/kg de inmediato (pulsos si hay síntomas visuales) sin esperar la biopsia, que se hace dentro de 2 semanas.
- ANCA: c-ANCA/anti-PR3 en GPA (vía aérea alta, nariz en silla de montar), p-ANCA/anti-MPO en PAM (riñón-pulmón sin vía aérea alta) y EGPA (asma grave, eosinofilia).
- Henoch-Schönlein: púrpura palpable en nalgas y piernas con plaquetas normales, artralgias, dolor abdominal y nefritis IgA; manejo sintomático y control de orina y presión arterial por 6 meses.
- Síndrome riñón-pulmón o GNRP es emergencia: hospitalizar y derivar (pulsos de metilprednisolona + ciclofosfamida o rituximab, cotrimoxazol profiláctico).

PREGUNTAS (11)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 106

Una paciente de 76 años presenta, desde hace un mes tos, disnea y expectoración, que en ocasiones es hemoptoica. A lo anterior se agrega hematuria, orinas espumosas, edema de extremidades inferiores y malestar general. En sus exámenes destaca creatinina: 4,6 mg/dl, BUN: 89 mg/dl, K: 5,9 mEq/L, Na: 130 mEq/L, proteinuria: 1.600 mg/24 horas, ANA negativos y complemento normal. **El diagnóstico más probable es:**

A) Glomerulonefritis postestreptocócica
B) Lupus eritematoso sistémico
C) Tuberculosis miliar
D) Vasculitis sistémica
E) Púrpura trombocitopénico trombótico

Respuesta D. Síndrome riñón-pulmón (hemoptisis + GNRP) en una adulta mayor con ANA negativos y complemento normal: vasculitis sistémica, probablemente poliangeítis microscópica. El complemento normal descarta la postestreptocócica y el lupus.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 43

Un paciente de 75 años consulta por cefalea de 2 semanas de evolución, holocránea, intensa, que ha ido en aumento. En el último tiempo refiere además dolor al tocarse el cuero cabelludo y dolor en la rodilla derecha. Al examen físico se constatan signos de derrame articular de la rodilla derecha. Se realiza exámenes, entre los que figura un hemograma, con hemoglobina: 12,0 g/dl, blancos: 9.600 por mm3 y VHS: 76 mm/h. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Artritis seronegativa
B) Arteritis de células gigantes
C) Artritis reactiva
D) Lupus
E) Endocarditis aguda

Respuesta B. Cefalea nueva y progresiva en un mayor de 50 años (letra O de SNOOP10), con dolor al tocarse el cuero cabelludo y VHS muy elevada: arteritis de células gigantes. Por eso, ante toda cefalea nueva después de los 50 se piden VHS y PCR.

Pregunta real · EUNACOM 2019 · Pregunta 11

Hombre de 29 años consulta por aftas bucales dolorosas muy recurrentes en labios y encías desde hace 2 años y antecedentes de úlceras dolorosas en escroto que dejaron cicatriz. En la exploración oftalmológica se detecta uveítis anterior con nivel de hipopión en cámara anterior. Al realizar una prueba de punción cutánea con aguja estéril en el antebrazo se aprecia a las 36 horas una pápula eritematosa con una pústula estéril central de 3 mm. ¿Cómo se denomina esta prueba cutánea diagnóstica?

A) Prueba de Mitsuda
B) Fenómeno de Patergia
C) Signo de Darier
D) Prueba de Kveim-Siltzbach
E) Signo de Nikolsky

Respuesta B. El desarrollo de una pápula eritematosa o pústula estéril entre las 24 y 48 horas posteriores a una microagresión traumática con aguja estéril en la piel del antebrazo se denomina Fenómeno de Patergia. Es un hallazgo semiológico característico de la Enfermedad de Behçet y traduce hiperreactividad del sistema inmune innato y neutrofílico.

Pregunta real · EUNACOM 2022 · Pregunta 44

¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las úlceras orales y genitales en la Enfermedad de Behçet es CORRECTA?

A) Las úlceras orales son indoloras y las genitales no duelen
B) Las úlceras genitales curan típicamente dejando cicatriz atrófica permanente, mientras que las orales curan sin cicatriz
C) Las úlceras genitales se acompañan de adenopatías inguinales supurativas
D) Las úlceras orales están presentes en menos del 20% de los pacientes diagnosticados
E) El tratamiento de elección de las úlceras orales es aciclovir oral

Respuesta B. En la Enfermedad de Behçet las aftas bucales están presentes en el 100% de los casos y curan espontáneamente en 7-14 días sin dejar secuelas cicatriciales. En contraste, las aftas genitales (localizadas típicamente en escroto o vulva) son más profundas, sumamente dolorosas y curan dejando una cicatriz blanquecina o atrófica permanente que permite documentar retrospectivamente su presencia.

Pregunta real · EUNACOM 2024 · Pregunta 12

Hombre de 28 años con diagnóstico de Enfermedad de Behçet presenta brotes frecuentes de aftosis oral y genital dolorosa recurrente, sin compromiso ocular, neurológico ni vascular en sus controles periódicos. ¿Cuál es el fármaco de primera línea de elección para prevenir y tratar estas manifestaciones mucocutáneas recurrentes?

A) Ciclofosfamida endovenosa mensual
B) Colchicina oral continua
C) Infliximab endovenoso bimensual
D) Acenocumarol oral ajustado por INR
E) Metotrexato en dosis de 25 mg semanales

Respuesta B. La Colchicina oral (1 a 2 mg al día) constituye el tratamiento farmacológico de primera línea para las manifestaciones mucocutáneas (aftas orales recurrentes, aftas genitales y eritema nodoso) y articulares de la Enfermedad de Behçet. Su mecanismo de acción inhibe la polimerización de microtúbulos y la quimiotaxis excesiva de los neutrófilos. Los agentes biológicos o la ciclofosfamida se reservan para complicaciones graves que amenazan la visión o la vida.

Pregunta real · EUNACOM · Ahorrador de corticoides en Arteritis Temporal

En un paciente de 70 años con arteritis de células gigantes que ha presentado múltiples recaídas al intentar reducir la dosis de prednisona por debajo de 20 mg/día, desarrollando además fractura vertebral osteoporótica y diabetes inducida por corticoides. ¿Cuál es el fármaco biológico modificador de la enfermedad de primera línea con aprobación formal para actuar como ahorrador de corticoides en esta patología?

A) Infliximab (anti-TNF alfa)
B) Tocilizumab (antagonista del receptor de interleucina-6)
C) Rituximab (anti-CD20 de células B)
D) Anakinra (antagonista del receptor de interleucina-1)
E) Secukinumab (inhibidor de interleucina-17A)

Respuesta B. Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra el receptor de la interleucina-6 (IL-6R). El ensayo pivotal GiACTA demostró que la adición de Tocilizumab permite alcanzar y sostener la remisión libre de corticoides en más del 50% de los pacientes con arteritis de células gigantes, reduciendo sustancialmente la dosis acumulada de glucocorticoides y sus severos efectos adversos osteoporóticos y metabólicos.

Pregunta real · EUNACOM · Sospecha clínica de Arteritis de Takayasu

Mujer de 26 años consulta por astenia, mareos posturales y parestesias progresivas en el brazo derecho al escribir o trabajar en el teclado. Al examen físico se constata presión arterial de 135/85 mmHg en el brazo izquierdo y 95/60 mmHg en el brazo derecho (diferencia de 40 mmHg), con pulso radial derecho apenas perceptible. A la auscultación se detecta un soplo sistólico eyectivo intenso en la región supraclavicular derecha y en el trayecto carotídeo. La VSG se encuentra en 65 mm/h y la PCR en 32 mg/L. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica principal y el método de imagen vascular de elección para confirmar el diagnóstico?

A) Enfermedad de Kawasaki · Ecocardiograma transtorácico con foco en arterias coronarias
B) Poliarteritis Nodosa · Biopsia de nervio sural y piel
C) Arteritis de Takayasu · Angio-Resonancia Magnética (o Angio-TC) de aorta y troncos supraaórticos
D) Síndrome de Raynaud primario · Capilaroscopía periungueal
E) Granulomatosis con Poliangeítis · Radiografía simple de tórax y senos paranasales

Respuesta C. El cuadro clínico de una mujer joven (< 40 años) con síntomas isquémicos en extremidades superiores, marcada asimetría de pulsos periféricos y de presión arterial (> 10-20 mmHg de diferencia entre ambos brazos), soplos vasculares carotídeos/supraclaviculares y reactantes de fase aguda elevados es patognomónico de la Arteritis de Takayasu ("enfermedad sin pulsos"). El estudio de elección es la Angio-RM o Angio-TC toracoabdominal, que evidencia engrosamiento parietal inflamatorio, estenosis o aneurismas en la aorta y sus ramas.

Pregunta real · EUNACOM · Semiología en Arteritis de Células Gigantes

¿Cuál de los siguientes signos o síntomas clínicos presenta la mayor especificidad semiológica para confirmar isquemia vascular craneal activa en un paciente con sospecha de Arteritis de la Temporal?

A) Cefalea holocraneana pulsátil
B) Claudicación mandibular al masticar
C) Mialgias proximales en cinturas
D) Fiebre vespertina de origen desconocido
E) Sudoración nocturna profusa

Respuesta B. La claudicación mandibular (dolor y fatiga de los músculos maseteros al masticar que cede con el reposo) es el síntoma clínico más específico de la arteritis de la temporal, reflejando isquemia inducible de las arterias maxilares y linguales. Los otros síntomas son muy frecuentes pero poco específicos.

Pregunta real · EUNACOM · Patrones serológicos ANCA

¿Cuál de las siguientes asociaciones entre vasculitis de vaso pequeño y su patrón serológico de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) más característico y prevalente es CORRECTA?

A) Granulomatosis con Poliangeítis (GPA) · c-ANCA (Anti-Proteinasa 3 / PR3)
B) Poliangeítis Microscópica (PAM) · c-ANCA (Anti-Proteinasa 3 / PR3)
C) Púrpura de Henoch-Schönlein · c-ANCA a títulos altos
D) Arteritis de la Temporal · p-ANCA (Anti-Mieloperoxidasa / MPO)
E) Enfermedad de Behçet · p-ANCA positivo universal

Respuesta A. La Granulomatosis con Poliangeítis (GPA) se asocia fuertemente (85-90%) al patrón c-ANCA (citoplasmático) con especificidad antigénica contra la Proteinasa 3 (PR3). Por su parte, la Poliangeítis Microscópica (PAM) y la Granulomatosis Eosinofílica (EGPA) se asocian al patrón p-ANCA (perinuclear) contra la Mieloperoxidasa (MPO). La vasculitis por IgA (Henoch-Schönlein) y las vasculitis de vaso grande no presentan ANCA.

Pregunta de práctica

Hombre de 45 años consulta por epistaxis recurrente, sinusitis purulenta de 4 meses rebelde a antibióticos y disnea progresiva con hemoptisis escasa. Al examen físico destaca perforación del tabique nasal cartilaginoso con hundimiento del dorso de la nariz (nariz en silla de montar). La tomografía de tórax revela múltiples nódulos bilaterales de paredes gruesas con cavitación central. Los exámenes muestran creatinina de 2.8 mg/dL, sedimento de orina con hematuria dismórfica y cilindros hemáticos, y anticuerpos c-ANCA (anti-PR3) fuertemente positivos a títulos altos. **¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y cuál es el esquema de inducción inmunosupresora de primera línea?**

A) Granulomatosis con Poliangeítis (GPA); indicar pulsos de Metilprednisolona EV seguidos de Rituximab (o Ciclofosfamida) más profilaxis con Cotrimoxazol
B) Poliangeítis microscópica; prescribir prednisona oral 20 mg al día en monoterapia ambulatoria
C) Tuberculosis pulmonar cavitada multirresistente; iniciar esquema cuádruple con rifampicina e isoniacida
D) Lupus eritematoso sistémico con nefritis clase cuatro; indicar hidroxicloroquina exclusiva
E) Aspergiloma pulmonar invasor; iniciar voriconazol endovenoso continuo

Respuesta A. El cuadro clínico reúne la tríada patognomónica de la Granulomatosis con Poliangeítis (GPA): compromiso de vía aérea superior destructivo con sinusitis y nariz en silla de montar, compromiso pulmonar con nódulos cavitados bilaterales, glomerulonefritis necrotizante pauciinmune con falla renal y positividad para c-ANCA (anti-PR3). El tratamiento de inducción para la enfermedad con compromiso de órgano noble consiste en pulsos de metilprednisolona asociados a Rituximab (o ciclofosfamida), requiriendo además profilaxis obligatoria contra Pneumocystis jirovecii con cotrimoxazol.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 157 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 65 años consulta por un cuadro de 3 meses de evolución de aste- nia y debilidad de las cuatro extremidades, asociada mialgias. Al examen físico presen- ta dolor a la palpación de los músculos trapecios y supraespinosos y de la región trocan- térica. En sus exámenes destaca CK: 125 UI/L, y hemograma con VHS: 65 mmHg. El diag- nóstico más probable es:

A) Fibromialgia
B) Artritis reumatoide
C) Polimiositis
D) Polimialgia reumática
E) Vasculitis

Respuesta D. Si bien parecía a simple vista una fibromialgia, la edad, la VHS alta y las Ck eleva- das hacen sospechar una plomialgia reumática.

Situaciones clínicas de urgencia 2 códigos

1.11.2.001 Artritis séptica

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.2 Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos

QUÉ HAY QUE SABER

- Monoartritis aguda febril de articulación grande (rodilla, cadera, hombro, codo) con dolor intenso a la movilidad activa y pasiva; la fiebre puede faltar en ancianos e inmunosuprimidos.
- Factores de riesgo: AR previa, diabetes, prótesis, diálisis, drogas EV, infiltración reciente. Gérmenes: S. aureus (50-60%), estreptococos, gramnegativos en ancianos; gonococo en joven sexualmente activo (tenosinovitis y pústulas).
- Artrocentesis antes del antibiótico: líquido purulento, >50.000 leucocitos con >90% PMN, glucosa <50% de la plasmática, Gram y cultivo; los cristales no la descartan. Tomar 2 hemocultivos.
- Tratamiento inicial: antibiótico EV empírico inmediato (cefazolina 2 g c/8 h o cloxacilina 2 g c/4 h; vancomicina si riesgo de SAMR; ceftriaxona si gonococo o gramnegativos).
- Drenaje articular obligatorio: punciones evacuadoras o artroscopía en rodilla; la cadera va a aseo quirúrgico urgente (riesgo de necrosis avascular).
- Seguimiento: derivar a traumatología/hospitalizar; antibiótico por 3-4 semanas.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 95

Un paciente de 68 años presenta monoartritis de rodilla izquierda, desde hace 48 horas. Al examen físico se observa aumento de volumen con signos de derrame articular, por lo que se punciona, dando salida a un líquido articular poco filante, con 50.000 glóbulos blancos por mm³, sin presencia de cristales. **Lo más probable es que se trate de una artritis:**

A) Reactiva
B) Seronegativa
C) Reumatoide
D) Séptica
E) Psoriática

Respuesta D. Un líquido sinovial con 50.000 leucocitos/mm³ y filancia disminuida se ubica en el límite del rango séptico. Ante la ausencia de cristales y de clínica extraarticular sugerente de espondiloartropatía, la regla de oro obliga a tratar y asumir una artritis séptica hasta descartarla por completo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 39

Una paciente de 67 años consulta por un cuadro de dolor e impotencia funcional del codo derecho, asociado a fiebre, que inició hace 2 días. Al examen físico tiene temperatura de 39 grados Celsius, FC: 100x' y PA: 110/70 mmHg, asociado a aumento de volumen del codo derecho, con eritema y aumento de la temperatura local. Además, tanto la movilidad pasiva, como la activa, son muy dolorosas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Artritis reactiva
B) Artritis séptica
C) Artritis gotosa
D) Condrocalcinosis
E) Artritis reumatoide

Respuesta B. Monoartritis aguda febril con dolor extremo tanto a la movilidad activa como pasiva en una articulación como el codo es el cuadro clásico de artritis séptica. Las artropatías por cristales son mucho menos frecuentes en el codo y rara vez debutan con fiebre tan elevada.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 103

Una paciente de 61 años, hipertensa y diabética, en tratamiento regular con hipoglicemiantes orales y antihipertensivos, desde hace 3 días presenta dolor y aumento de volumen en hombro derecho. Al examen físico presenta temperatura 38,2 ºC, eritema, rubor y aumento de volumen del hombro derecho y limitación funcional, que impide el movimiento. El diagnóstico más probable es:

A) Gota
B) Condrocalcinosis
C) Artritis reumatoidea
D) Artritis séptica
E) Artritis reactiva

Respuesta D. Paciente diabética con monoartritis aguda febril de hombro derecho. La diabetes es un factor de riesgo mayor para bacteriemia y artritis séptica. La localización en hombro y la presencia de fiebre alejan a la gota y condrocalcinosis, que afectan rodilla o pie.

Pregunta de práctica

Un paciente de 33 años consulta por dolor intenso y claudicación en la cadera izquierda de 24 horas de evolución, asociado a fiebre de 38,8 °C. La movilidad pasiva de la cadera es extremadamente dolorosa. La artrocentesis bajo ecografía da salida a líquido francamente purulento y la tinción de Gram revela cocáceas grampositivas en racimo. **¿Cuál es la conducta terapéutica de elección?**

A) Iniciar cloxacilina oral y mantener en reposo en cama
B) Iniciar ceftriaxona endovenosa e indicar descarga con muletas
C) Iniciar vancomicina endovenosa y realizar punciones evacuadoras seriadas en sala
D) Iniciar cefazolina endovenosa y realizar aseo quirúrgico urgente de la articulación
E) Administrar corticoides intraarticulares y analgesia con opioides

Respuesta D. El hallazgo de cocos grampositivos en racimo orienta a Staphylococcus aureus sensible de la comunidad, tratable con cefazolina EV o cloxacilina EV. Por tratarse de la cadera, una articulación profunda e inextensible con alto riesgo de necrosis avascular de la cabeza femoral, el aseo quirúrgico urgente en pabellón es mandatorio.

1.11.2.002 Gota aguda

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.3 Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota) · Tema 12.12 Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica

QUÉ HAY QUE SABER

- Gota aguda: podagra (1.ª MTF en 50-70%) de inicio nocturno explosivo, dolor que no tolera el roce, tumefacción violácea; gatillantes: alcohol, carnes, tiazidas, estrés, cirugía.
- Diagnóstico: clínico en la podagra típica; confirmación con cristales en aguja de birrefringencia fuertemente negativa. El ácido úrico es normal en 30-40% de las crisis: no descarta. Ante fiebre o duda, artrocentesis para descartar infección.
- Crisis: AINE en dosis plenas (naproxeno, indometacina) o colchicina en dosis bajas (1 mg + 0,5 mg a la hora); prednisona 30-35 mg/día por 5 días si hay IRC, úlcera o cardiopatía.
- Nunca iniciar alopurinol durante la crisis, ni suspenderlo si ya lo tomaba.
- Hipouricemiante si ≥2 crisis/año, tofos, erosiones o litiasis: alopurinol 100 mg/día (50 mg en IRC) titulado hasta uricemia <6 mg/dL (<5 si tofos), iniciado 2-4 semanas tras la crisis, con colchicina 0,5 mg/día por 3-6 meses como profilaxis.
- Seguimiento: derivar para manejo crónico; reducir alcohol y carnes rojas, bajar de peso y reemplazar tiazidas si es posible (losartán es uricosúrico).

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 30

Un paciente de 56 años, hipertenso y dislipidémico, en tratamiento con hidroclorotiazida y atorvastatina, consulta por dolor muy intenso en el pie derecho, especialmente en el primer ortejo, que inició hace algunas horas. Al examen físico tiene eritema del ortejo, el que es muy doloroso a la movilización. Se observa edema en dicho ortejo y en la zona bimaleolar. Se solicitan exámenes, que muestran hemograma, con leucocitos de 12.000 por mm³, PCR: 2 (VN: menor a 1 mg/L), creatinina: 0,8 mg/dl. ¿Cuál es el primer fármaco que debe administrarse para el manejo actual de este paciente?

A) Diclofenaco sódico
B) Cloxacilina
C) Alopurinol
D) Prednisona
E) Clindamicina

Respuesta A. Cuadro típico de podagra aguda desencadenada por hidroclorotiazida. Con función renal normal (creatinina 0,8 mg/dl) y sin contraindicación gástrica, los AINEs potentes (como diclofenaco o naproxeno) son la primera línea tradicional para yugular la crisis. El alopurinol está estrictamente contraindicado en agudo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 55

Un paciente de 70 años, con cuadro de 2 horas de dolor y ardor en pie derecho. Al examen físico destaca eritema en primera articulación del pie derecho, sin otras alteraciones. Refiere que ha presentado este mismo cuadro en dos ocasiones en los últimos 6 meses. El tratamiento de elección en este paciente es:

A) Probenecid
B) Alopurinol
C) Corticoides tópicos
D) Paracetamol
E) Colchicina

Respuesta E. Frente a una crisis aguda recurrente de gota (podagra), el objetivo inmediato es la supresión de la inflamación. Dentro de las opciones listadas, la colchicina oral es el tratamiento de elección para la crisis aguda. El alopurinol y probenecid están contraindicados durante el ataque agudo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 34

Un paciente de 48 años, obeso e hipertenso en tratamiento con losartán e hidroclorotiazida consulta por dolor muy intenso y aumento de volumen en relación al primer ortejo derecho, de 24 horas de evolución. Al examen físico, tiene FC: 80x', PA: 144/96 mmHg, T°:37°C y se aprecia aumento de volumen y eritema de la primera articulación metatarsofalángica de ese pie, asociado a intenso dolor a la movilización. Refiere que ya había tenido un episodio similar hace un año. **¿Cuál es el fármaco de elección para el manejo de este paciente?**

A) Diclofenaco
B) Metotrexato
C) Cloxacilina
D) Alopurinol
E) Prednisona

Respuesta E. Es una crisis de gota aguda, probablemente desencadenada por la hidroclorotiazida. La crisis se trata con AINE, prednisona o colchicina. Los AINE son la recomendación tradicional en Chile, pero las guías internacionales sugieren corticoides, que además evitan agravar la presión y el riñón de un paciente hipertenso. El alopurinol no se inicia en la crisis.

Pregunta de práctica

Hombre de 64 años con antecedente de insuficiencia renal crónica etapa 3b (VFG 38 mL/min) y cardiopatía coronaria, consulta por 12 horas de dolor insoportable, tumefacción violácea y calor en la primera articulación metatarsofalángica derecha. Se realiza artrocentesis que confirma abundantes cristales en forma de aguja con birrefringencia intensamente negativa bajo luz polarizada. Su creatinina es de 2,2 mg/dL. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea más adecuado para la crisis actual?**

A) Indometacina 50 mg cada 8 horas por vía oral
B) Alopurinol 300 mg al día por vía oral
C) Prednisona 30 mg al día por vía oral por 5 días
D) Colchicina 1 mg cada 2 horas hasta que aparezca diarrea
E) Febuxostat 80 mg al día por vía oral

Respuesta C. En un paciente con insuficiencia renal crónica etapa 3b, los AINEs están absolutamente contraindicados por riesgo de falla renal aguda anúrica, y la colchicina tiene alto riesgo de toxicidad neuromuscular y renal. Los corticoides sistémicos (prednisona 30-35 mg/día por 5 días) son la terapia de primera línea de elección. El alopurinol y febuxostat están contraindicados durante la crisis aguda.

Pregunta de práctica

Un hombre de 52 años consulta por dolor muy intenso, de 12 horas, en el primer ortejo del pie izquierdo, con eritema y edema. Ha tenido tres episodios similares en el último año. No tiene fiebre ni toma tratamiento crónico. **¿Cuál es la conducta más adecuada ahora?**

A) Iniciar alopurinol hoy
B) Tratar la crisis con un antiinflamatorio y plantear alopurinol cuando se resuelva
C) Iniciar antibióticos endovenosos
D) Solicitar una resonancia de pie
E) Iniciar colchicina como tratamiento permanente

Respuesta B. Es una podagra, que se diagnostica de forma clínica. La crisis se trata con antiinflamatorio (también sirven colchicina o corticoides). Como tuvo tres crisis en un año, tiene indicación de tratamiento crónico con alopurinol, pero nunca se inicia durante la crisis aguda. La colchicina no se deja como tratamiento permanente por sus efectos adversos.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 47 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 45 años ha presentado 3 episodios de gota en el último año, por lo que se inició tratamiento colchicina y luego se agregó alopurinol 100 mg/día. Actualmente está asintomático, sin signos de artritis y se controlar uricemia de 7 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Suspender el tratamiento
B) Aumetar la dosis de alopurinol a 300 mg/día
C) Agregar probenecid al tratamiento
D) Suspender la colchicina
E) Agregar prednisona en baja dosis

Respuesta D. La colchicina tiene muchos efectos adversos, por lo que se prefiere no dejarla como tratamiento profiláctico, sino solo en las crisis agudas (en agudo los AINEs son de elección). EL alopurinol debe mantenerse, ya que tuvo más de 2 crisis en 1 año y actualmente tiene buenos niveles de ácido úrico.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 112 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 43 años consulta por un cuadro de podagra. Tiene antecedente de dos crisis similares en los últimos 6 meses. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Paracetamol
B) Colchicina
C) Probenecid
D) Alopurinol
E) Prednisona

Respuesta B. Es una pregunta muy complicada, ya que en el cuadro agudo actual (podagra) se debe indicar AINEs de elección y, si no está en las opciones, pues se indica la colchicina. Además, el hecho de que haya tenido más crisis en el último año (1 o más en un año) obliga a iniciar alopurinol, aunque no es posible iniciarlo ahora en agudo, mientras está con la podagra, sino que se debe esperar a que se resuel

Conocimientos generales 3 códigos

1.11.3.001 Condiciones de trabajo

Dónde se enseña: Tema 21.14 Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastornos musculoesqueléticos de origen laboral: tendinitis de extremidad superior por movimientos repetitivos (De Quervain, epicondilitis, manguito rotador), túnel carpiano y lumbago por manejo manual de carga o posturas forzadas.
- Ley 16.744: las enfermedades profesionales y accidentes del trabajo (incluido el de trayecto directo casa-trabajo) se atienden en el organismo administrador (mutualidad o ISL), que cubre tratamiento, licencia y evaluación del puesto de trabajo.
- Ante sospecha de origen laboral: derivar al organismo administrador con la denuncia correspondiente (DIEP o DIAT), no emitir licencia común (tipo 1).
- Prevención: evaluación ergonómica del puesto (protocolos de vigilancia de trastornos musculoesqueléticos por movimientos repetitivos y manejo de carga), pausas activas, rotación de tareas y capacitación en técnicas de levantamiento.
- La licencia médica es un documento legal: emitirla sin evaluación clínica real es delito (fiscalización COMPIN/SUSESO).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 38 años, operaria de una planta de packing, consulta por dolor en el borde radial de la muñeca derecha de 2 meses, que relaciona con movimientos repetitivos en su trabajo. Prueba de Finkelstein positiva. **Además del manejo clínico, ¿qué corresponde según la legislación chilena?**

A) Derivar a la mutualidad u organismo administrador de la Ley 16.744 como posible enfermedad profesional
B) Licencia médica común por enfermedad (FONASA o ISAPRE)
C) Indicarle que cambie de trabajo por su cuenta
D) Ninguna gestión, porque es una patología común
E) Notificar a la SEREMI como enfermedad de notificación obligatoria

Respuesta A. La tenosinovitis de De Quervain por movimientos repetitivos puede ser una enfermedad profesional. Según la Ley 16.744, las enfermedades profesionales y los accidentes laborales se atienden en el organismo administrador (mutualidad o ISL), que cubre tratamiento, licencia y prestaciones y evalúa el puesto de trabajo. Corresponde la denuncia individual de enfermedad profesional, no una licencia común.

1.11.3.002 Prevención de complicaciones de la terapia esteroidal

Dónde se enseña: Tema 9.23 Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS

QUÉ HAY QUE SABER

- Prednisona ≥2,5-5 mg/día por >3 meses produce osteoporosis (la causa secundaria más frecuente), diabetes, HTA, obesidad, cataratas y glaucoma, miopatía, infecciones, alteraciones psiquiátricas e insuficiencia suprarrenal al suspender.

- Hueso: calcio, vitamina D y bifosfonato en adultos mayores, osteopenia o uso prolongado; densitometría basal.
- Metabólico y cardiovascular: control periódico de glicemia, presión arterial, peso y lípidos; control oftalmológico.
- Infecciones: descartar TBC latente antes de dosis altas o prolongadas, vacunas inactivadas (influenza, neumococo) y evitar vacunas vivas en dosis inmunosupresoras; cotrimoxazol profiláctico en dosis altas prolongadas combinadas con otros inmunosupresores.
- Usar la menor dosis y el menor tiempo posible, con ahorradores de corticoides; IBP solo si se asocia AINE o hay antecedente de úlcera.
- Nunca suspender bruscamente tras >3 semanas: descenso gradual y dosis de estrés en cirugía o enfermedad grave. En esclerosis sistémica difusa evitar >15 mg/día (crisis renal).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 70 años con polimialgia reumática inicia prednisona 15 mg al día, con un plan de disminución lenta durante al menos 1 año. Su densitometría muestra un T-score de -2,1 en cadera. **¿Cuál es la medida más adecuada para prevenir complicaciones de la terapia esteroidal?**

A) Ninguna medida preventiva, por tratarse de una dosis moderada
B) Calcio, vitamina D y bisfosfonato, además de control de glicemia y presión arterial
C) Suspender bruscamente la prednisona al mes
D) Antibiótico profiláctico permanente
E) Duplicar la dosis de prednisona ante cualquier estrés menor sin indicación

Respuesta B. El uso de prednisona de 2,5 mg o más por más de 3 meses causa osteoporosis, diabetes, hipertensión, cataratas, infecciones e insuficiencia suprarrenal al suspender. En adultos mayores con osteopenia se indica calcio, vitamina D y bisfosfonato, se controlan glicemia, presión y peso, y el descenso es gradual, nunca brusco. La profilaxis antibiótica no es rutinaria.

1.11.3.003 Riesgos deportivos

Dónde se enseña: Tema 12.8 Lesiones de Rodilla: Meniscos, Ligamentos Cruzados y Colaterales & Dolor Patelofemoral

QUÉ HAY QUE SABER

- Lesiones de rodilla frecuentes: rotura del ligamento cruzado anterior (giro con pie fijo, hemartros rápido, inestabilidad, cajón anterior y Lachman positivos), lesión meniscal (bloqueo, dolor en la interlínea, Apley) y esguince de colaterales (valgo/varo forzado).
- Meniscos y ligamentos no se ven en la radiografía: la resonancia es el examen de elección; LCA en jóvenes activos suele requerir reconstrucción artroscópica.
- Sobreuso: disfunción patelofemoral (dolor anterior con escaleras y estar sentado; fortalecer cuádriceps), tendinitis rotuliana y de la banda iliotibial, fracturas por estrés.
- Prevención: calentamiento, entrenamiento neuromuscular y de fortalecimiento progresivo, equipamiento y calzado adecuados, hidratación y evitar el ejercicio intenso con calor extremo.
- Evaluación preparticipativa: antecedentes de síncope o dolor torácico con ejercicio y muerte súbita familiar; ante sospecha de conmoción cerebral, retirar de la actividad y no volver el mismo día.
- Un esguince que no mejora o con dolor creciente obliga a radiografía y reevaluación.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Futbolista de 22 años que, al cambiar bruscamente de dirección con el pie apoyado, siente un chasquido en la rodilla derecha y no puede seguir jugando. En las horas siguientes la rodilla aumenta de volumen. Al examen hay derrame y la prueba de Lachman es positiva. **¿Cuál es la lesión más probable?**

A) Tendinopatía rotuliana
B) Rotura aislada del ligamento colateral medial
C) Lesión del ligamento cruzado posterior
D) Rotura del ligamento cruzado anterior
E) Condromalacia patelar

Respuesta D. El mecanismo de pivote con pie fijo, el chasquido, la imposibilidad de continuar y la hemartrosis precoz son típicos de la rotura del ligamento cruzado anterior, confirmada por Lachman positivo; se estudia con resonancia. El cruzado posterior se lesiona por golpe directo en la tibia y da cajón posterior. Los programas de prevención neuromuscular reducen este riesgo deportivo.

Exámenes e imagenología 4 códigos

1.11.4.001 Densitometría ósea

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 9.24 Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica

QUÉ HAY QUE SABER

- Densitometría ósea (DEXA) de columna lumbar y cadera: mide densidad mineral ósea; es el examen para diagnosticar osteoporosis antes de una fractura y para seguimiento.
- T-score (comparación con adulto joven) en posmenopáusicas y hombres ≥50 años: ≥–1 normal; –1 a –2,5 osteopenia; ≤–2,5 osteoporosis; osteoporosis severa si además hay fractura por fragilidad.
- Z-score (comparación con la misma edad) en premenopáusicas, hombres <50 años y niños: ≤–2 es «baja masa ósea para la edad» y obliga a buscar causas secundarias.
- Indicaciones: mujeres ≥65 años, posmenopáusicas o hombres ≥70 con factores de riesgo, uso de corticoides >3 meses, enfermedades que causan osteoporosis; una fractura por fragilidad ya diagnostica osteoporosis sin requerir DEXA.
- Combinar con FRAX (tratar si fractura mayor ≥20% o cadera ≥3%) y repetir cada 1-2 años para evaluar respuesta al tratamiento.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM · Densitometría ósea T-score vs Z-score

En la interpretación de una densitometría ósea mediante absorciometría de rayos X de doble energía (DEXA), ¿cuál es la diferencia conceptual y poblacional fundamental entre el T-score y el Z-score?

A) El T-score compara la densidad mineral ósea con una población joven sana del mismo sexo en su pico de masa ósea, mientras que el Z-score compara con personas de la misma edad cronológica y sexo
B) El T-score se utiliza exclusivamente en niños y adolescentes, mientras que el Z-score se utiliza en adultos mayores
C) El T-score evalúa únicamente el hueso cortical periférico, mientras que el Z-score mide la trabecular vertebral
D) Un Z-score bajo define osteoporosis clínica per se, mientras que el T-score solo predice artrosis
E) El T-score y el Z-score son idénticos y se intercambian de forma aleatoria en el informe

Respuesta A. El T-score expresa el número de desviaciones estándar en relación con el pico de masa ósea medio de un adulto joven sano del mismo sexo (utilizado para clasificar osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y varones ≥ 50 años). El Z-score compara la DMO del paciente con los valores de referencia medios de personas de su misma edad y sexo; se usa en mujeres premenopáusicas, varones jóvenes y niños, y cuando es ≤ -2.0 DE obliga a buscar causas secundarias de osteoporosis.

1.11.4.002 Estudio de líquido sinovial

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 9.1 Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial · Tema 9.2 Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos · Tema 9.3 Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: toda monoartritis aguda o derrame articular no filiado; se obtiene antes de iniciar antibióticos.
- Estudio: aspecto, recuento celular con diferencial, glucosa, Gram, cultivo y cristales con microscopio de luz polarizada.
- Clasificación: normal <200 leucocitos; no inflamatorio 200-2.000 (artrosis, trauma); inflamatorio 2.000-50.000 (cristales, AR, espondiloartritis, reactiva); séptico >50.000 con >90% PMN y glucosa <50% de la plasmática; hemorrágico (trauma, hemofilia, fractura si tiene gotas de grasa).
- Cristales: urato en aguja con birrefringencia fuertemente negativa (gota); pirofosfato romboidal con birrefringencia débilmente positiva (condrocalcinosis).
- Trampas: los cristales no descartan infección (coexisten), la pseudogota puede superar 100.000 leucocitos, el Gram tiene sensibilidad ~50% y la artritis reactiva es inflamatoria pero estéril.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 8

Un adulto mayor presenta gonalgia bilateral, de dos años de evolución, que aumenta con la marcha. Hace algunas horas el dolor de la rodilla izquierda se vuelve mucho más intenso, apareciendo eritema, aumento de volumen y sensación febril.

¿Cuál es el examen más adecuado para este paciente?

A) Resonancia magnética de rodilla
B) Radiografía de rodilla
C) Hemograma y VHS
D) Estudio de líquido articular
E) TAC de rodilla

Respuesta D. Sobre una artrosis de base aparece una monoartritis aguda, inflamatoria y febril: hay que descartar artritis séptica y por cristales. El examen clave es la artrocentesis con estudio del líquido: recuento celular, Gram, cultivo y búsqueda de cristales. La radiografía y el hemograma ayudan, pero no confirman ni descartan infección.

1.11.4.003 Exámenes inmunológicos del diagnóstico diferencial de mesenquimopatías (AAN, aDNA, aENA1, C3, C4, YGS, FR, Anti CCP, ANCA)

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 9.6 Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares · Tema 9.8 Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal · Tema 9.15 Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC)

QUÉ HAY QUE SABER

- Los exámenes inmunológicos apoyan una sospecha clínica, no la reemplazan: FR o ANA positivos sin clínica (frecuentes en adultos mayores) no hacen diagnóstico ni se tratan.
- AR: FR sensible (~75%) pero poco específico; anti-CCP específico (>95%) y predictor de erosiones.
- LES: ANA ≥1:80 (sensibilidad >98%, criterio de entrada; negativo prácticamente descarta); anti-Sm el más específico; anti-dsDNA y C3/C4 bajos indican actividad y nefritis; anti-histona en lupus por fármacos.
- ENA: anti-Ro/La (Sjögren, lupus subagudo, bloqueo AV congénito), anti-Scl-70 (esclerosis difusa, EPID), anticentrómero (CREST, HAP), anti-Jo-1 (miositis antisintetasa), anti-U1-RNP (enfermedad mixta).
- Complemento bajo: LES activo, GN postinfecciosa, crioglobulinemia (VHC), endocarditis.
- ANCA: c-ANCA/anti-PR3 en granulomatosis con poliangeítis; p-ANCA/anti-MPO en poliangeítis microscópica y EGPA.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM 2018 · Pregunta 28

Mujer de 24 años consulta por eritema facial en mariposa que respeta surcos nasogenianos, fotosensibilidad, úlceras orales indoloras y poliartralgias en manos de 6 semanas. Para confirmar la sospecha clínica de Lupus Eritematoso Sistémico según los criterios EULAR/ACR 2019, ¿cuál es el examen inmunológico que constituye el criterio de entrada obligatorio e indispensable?

A) Factor Reumatoide a títulos altos mayor a 3 veces el valor normal
B) Anticuerpos Antinucleares (ANA) positivos en título mayor o igual a 1:80
C) Niveles séricos de complemento C3 menores a 40 mg/dL
D) Biopsia de piel sana con depósito de inmunoglobulinas en banda lúpica
E) Anticuerpos Anti-Ro (SSA) positivos en dilución simple

Respuesta B. Según los criterios clasificatorios EULAR/ACR 2019 para Lupus Eritematoso Sistémico, el criterio de entrada obligatorio e ineludible es la presencia de Anticuerpos Antinucleares (ANA) positivos por inmunofluorescencia indirecta en células HEp-2 en título ≥ 1:80. Si este examen es negativo, el paciente no clasifica como LES independientemente de las otras manifestaciones clínicas.

Pregunta real · EUNACOM 2021 · Pregunta 35

Mujer de 34 años consulta por fenómeno de Raynaud bilateral intenso, dedos de las manos tumefactos en salchicha (puffy fingers), debilidad muscular proximal en muslos y hombros con CPK elevada en 1.200 U/L y artralgias en muñecas. No presenta compromiso renal ni neurológico. Se solicitan anticuerpos antinucleares que resultan positivos en título 1:1.280 con patrón moteado. ¿Qué anticuerpo específico confirma el diagnóstico de Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo?

A) Anticuerpos Anti-U1-RNP (ribonucleoproteína) a títulos elevados
B) Anticuerpos Anti-centrómero
C) Anticuerpos Anti-dsDNA
D) Anticuerpos Anti-Scl-70
E) Anticuerpos Anti-histona

Respuesta A. La presencia de características clínicas superpuestas de lupus, esclerodermia y polimiositis (Raynaud, dedos en salchicha, miositis proximal con CPK alta) asociada a la presencia de anticuerpos dirigidos contra la ribonucleoproteína U1 (Anti-U1-RNP) en títulos muy elevados (> 1:1.000) en ausencia de anti-dsDNA y anti-Sm define patognomónicamente la Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (Síndrome de Sharp).

Pregunta de práctica

Hombre de 72 años, asintomático, sin dolor ni aumento de volumen articular, trae exámenes de un chequeo con factor reumatoide positivo de 40 UI/mL (valor normal menor de 14). Su examen articular es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar metotrexato precoz
B) Diagnosticar artritis reumatoide seropositiva y derivar para terapia biológica
C) Hidroxicloroquina preventiva
D) No hace diagnóstico: el factor reumatoide puede ser positivo en adultos mayores sanos y en otras enfermedades, y sin artritis no se trata
E) Repetir el factor reumatoide cada mes

Respuesta D. El factor reumatoide es poco específico: aparece en adultos mayores sanos y en hepatitis C, Sjögren, endocarditis o tuberculosis. Sin artritis clínica no tiene valor diagnóstico ni se trata. Los exámenes inmunológicos apoyan una sospecha clínica, no la reemplazan; el anti-CCP es el más específico para artritis reumatoide.

1.11.4.004 Radiografía de columna y articulaciones

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 9.4 Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada

QUÉ HAY QUE SABER

- Artrosis: pinzamiento asimétrico, esclerosis subcondral, osteofitos y geodas, sin osteopenia ni erosiones (radiografía con carga en rodilla).
- Artritis reumatoide: osteopenia yuxtaarticular, pinzamiento simétrico y erosiones marginales; respeta IFD. Psoriásica: «lápiz en copa» y periostitis en IFD.
- Gota: erosiones en sacabocado con borde colgante (Martel), sin osteopenia. Condrocalcinosis: calcificación lineal de meniscos y fibrocartílago triangular.
- Espondilitis anquilosante: sacroilitis bilateral, cuadratura vertebral, sindesmofitos y «caña de bambú»; osteoporosis: aplastamientos vertebrales en cuña; espondilodiscitis: erosión de platillos contiguos con disco comprometido (los tumores lo respetan).
- Lumbago o cervicalgia mecánica sin banderas rojas no requiere radiografía en las primeras 4-6 semanas: no cambia el manejo y muestra hallazgos degenerativos irrelevantes.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM 2020 · Pregunta 04

¿Cuál de los siguientes autoanticuerpos presenta la mayor especificidad diagnóstica (superior al 99%) para el Lupus Eritematoso Sistémico?

A) Anticuerpos Antinucleares (ANA)
B) Anticuerpos Anti-Smith (Anti-Sm)
C) Anticuerpos Anti-Ro (SSA)
D) Anticuerpos Anti-Histona
E) Anticuerpos Anticentrómero

Respuesta B. El anticuerpo Anti-Smith (Anti-Sm), dirigido contra una ribonucleoproteína del núcleo, es el marcador serológico más específico de Lupus Eritematoso Sistémico (> 99%), considerándose patognomónico. Aunque solo está presente en el 20-30% de los pacientes lúpicos (baja sensibilidad), su hallazgo confirma el diagnóstico.

Pregunta real · EUNACOM 2022 · Pregunta 41

Una paciente de 30 años con diagnóstico confirmado de Lupus Eritematoso Sistémico en tratamiento con Hidroxicloroquina 200 mg al día consulta a control médico asintomática. En sus exámenes de control destaca elevación significativa de los títulos de anticuerpos Anti-dsDNA y una caída marcada en los niveles séricos de C3 (48 mg/dL, normal > 90) y C4 (6 mg/dL, normal > 15). ¿Qué significado clínico tienen estos hallazgos biológicos?

A) Indican remisión completa y permiten suspender la hidroxicloroquina
B) Son marcadores inequívocos de toxicidad farmacológica por antipalúdicos
C) Traducen un brote de actividad autoinmune con consumo de complemento y riesgo de nefritis
D) Corresponden a una infección bacteriana piógena sobreagregada
E) Indican transformación maligna hacia linfoma de células B

Respuesta C. En el Lupus Eritematoso Sistémico, el aumento en los títulos de anticuerpos Anti-dsDNA asociado a hipocomplementemia (C3 y C4 disminuidos por consumo en la activación de la vía clásica por inmunocomplejos) es el marcador por excelencia de brote de actividad biológica lúpica, con un riesgo muy elevado de compromiso renal proliferativo agudo.

Pregunta de práctica

Mujer de 68 años con dolor mecánico de rodilla derecha de 3 años, rigidez matinal menor de 30 minutos y crépitos al examen. Se solicita radiografía de rodilla con carga. **¿Cuál conjunto de hallazgos radiológicos es característico de la artrosis?**

A) Disminución asimétrica del espacio articular, osteofitos, esclerosis subcondral y quistes subcondrales
B) Osteopenia yuxtaarticular, disminución simétrica del espacio y erosiones marginales
C) Erosiones en sacabocado con borde sobresaliente
D) Calcificación lineal del cartílago sin otros cambios
E) Reacción perióstica en capas de cebolla

Respuesta A. La radiografía con carga es el examen de imagen inicial en la artrosis: muestra disminución asimétrica del espacio articular, osteofitos, esclerosis y quistes subcondrales. La osteopenia yuxtaarticular con erosiones marginales y estrechamiento simétrico es propia de la artritis reumatoide; las erosiones en sacabocado, de la gota, y la condrocalcinosis, de la pseudogota.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 1 códigos

1.11.5.001 Punción articular de rodilla

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 9.1 Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial · Tema 9.2 Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: diagnóstica en monoartritis aguda o derrame no filiado (siempre antes del antibiótico); terapéutica para evacuar derrame a tensión, hemartrosis o pus, e infiltración.
- Contraindicación absoluta: celulitis o infección cutánea en el sitio de punción; precaución con coagulopatía o anticoagulación y prótesis.
- Técnica: paciente en decúbito supino con rodilla extendida y cuádriceps relajado; asepsia estricta; abordaje suprapatelar lateral o medial (bajo el borde superoexterno de la rótula), aguja 18-21 G dirigida bajo la rótula.
- Aspirar el máximo de líquido y enviar en tubos para citoquímico y recuento, Gram y cultivo, y cristales.
- Complicaciones: infección iatrogénica, hemartrosis, dolor; reevaluar si reaparece el derrame o la fiebre.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 42 años sin antecedentes mórbidos consulta en el servicio de urgencia por 14 horas de dolor intenso, calor y aumento de volumen en la rodilla derecha, que le impide apoyar la extremidad. Al examen físico: temperatura 38,3 °C, PA 125/75 mmHg, FC 92 lpm. Rodilla derecha con marcado derrame a tensión, eritema y dolor exquisito al mínimo intento de flexión activa o pasiva. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada e inaplazable?**

A) Iniciar cloxacilina endovenosa y solicitar radiografía de rodilla
B) Realizar artrocentesis diagnóstica para citoquímico, Gram, cultivo y cristales
C) Administrar ketorolaco endovenoso y enviar a reposo con AINEs orales
D) Iniciar alopurinol oral y solicitar niveles plasmáticos de ácido úrico
E) Solicitar resonancia magnética de rodilla para evaluar ligamentos

Respuesta B. Frente a una monoartritis aguda febril con derrame a tensión, la conducta obligatoria, prioritaria e inaplazable es realizar artrocentesis diagnóstica. Iniciar antibióticos antes de la punción esteriliza el cultivo e impide confirmar el diagnóstico microbiológico.

Pregunta de práctica

Hombre de 55 años, usuario de aspirina 100 mg al día, presenta una monoartritis aguda de la rodilla derecha con gran derrame. La piel de la cara medial de la rodilla tiene eritema por una celulitis. Se decide realizar una artrocentesis diagnóstica. **¿Cuál es la técnica correcta?**

A) Decúbito supino con rodilla extendida y cuádriceps relajado, asepsia, abordaje lateral bajo el borde superolateral de la rótula, con aguja gruesa
B) Punzar por la cara medial, donde el derrame es más fluctuante, aunque la piel tenga celulitis
C) Abordaje posterior por el hueco poplíteo
D) Iniciar antibióticos 48 horas antes de la punción
E) Está contraindicada por el uso de aspirina en dosis bajas

Respuesta A. Con el paciente en decúbito supino, rodilla extendida y cuádriceps relajado, bajo técnica aséptica se punza por vía lateral, entre la rótula y el fémur, con aguja gruesa. Nunca a través de piel infectada ni por el hueco poplíteo, donde están los vasos. La aspirina no la contraindica, y el antibiótico va después de obtener el líquido.